

Pasuruan, 27 April 2026

Nomor : 709/RSPHS/E-BLS/DIR/IV/2026
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Surat Balasan Permohonan Benchmarking Data

Kepada Yth.
dr. Resti Lestantini, M. Kes
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan benchmarking data capaian mutu dan surveilans HAI's pada bulan Januari – Juni 2025 (Semester I) dan Juli – Desember 2025 (Semester II), bersama ini kami sampaikan data yang dimaksud sebagaimana terlampir. Data yang kami peroleh hanya dapat diakses oleh Tim PMKP dan PPI sehingga Kerahasiaan data dapat dipertanggungjawabkan, penyimpanan data dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, selebihnya akan dilakukan pemusnahan data (dihapus).

Adapun terkait informasi dan komunikasi dapat menghubungi Lidia Puspita Kencana, S.K.M. (085235384897)

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo,



Ns. Heni Indra Wulansari, M.Kep

Tembusan :
Tim PMKP RS Prima Husada Malang

Lampiran

Surat Balasan Permohonan Benchmarking data

Nomor : 709/RSPHS/E-BLS/DIR/IV/2026

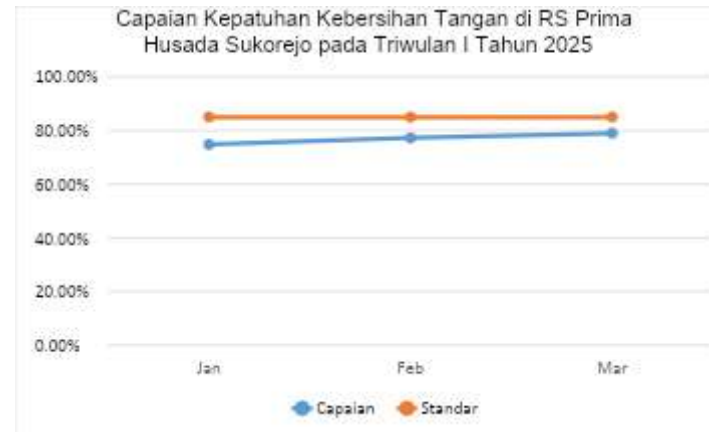
A. Capaian Indikator Mutu Nasional di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

Berikut merupakan tabel capaian Indikator Mutu Nasional (IMN) Triwulan I di RS Prima Husada Sukorejo

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		Januari	Februari	Maret			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	74,75%	77,24%	78,95%	≥85%	76,98%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	89,64%	89,87%	84,84%	100%	88,12%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	98,30%	99,76%	99,66%	100%	99,24%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	95,45%	92,31%	100%	≥80%	95,92%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	71,25%	68,24%	45,81%	≥80%	61,77%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	0%	3,43%	1,08%	≤5%	1,50%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	71,77%	72,57%	76,56%	≥80%	73,63%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,70%	96,98%	98,70%	≥80%	98,46%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	95,95%	96,65%	96,25%	100%	96,28%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	≥76.61%	94,41%	Dipertahankan

Analisis Hasil Capaian Indikator Mutu Nasional (IMN) Triwulan I di RS Prima Husada Sukorejo

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan I yakni mencapai 76,98%. Terlihat adanya tren peningkatan dari waktu ke waktu yaitu dari 74,75% pada bulan Januari menjadi 78,95% pada Bulan Maret 2025. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu $\geq 85\%$.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada bulan Triwulan I < 85% yakni 76,98%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan saat ini sebesar 76,98%. - Tujuan: Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan menjadi $\geq 85\%$ dalam 3 bulan. - Rencana Aksi:

	- Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO. - Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan. - Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI - Memberikan umpan balik langsung dan bersifat konstruktif kepada tenaga kesehatan. - Memberikan penghargaan kepada individu atau unit kerja dengan tingkat kepatuhan tertinggi. - Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.
Do	- Edukasi ulang dilaksanakan kepada seluruh tenaga kesehatan pada awal bulan - Poster, banner atau video ditempatkan di ruang perawatan, IGD, dan poli rawat jalan - Supervisi awal dilakukan oleh Tim PPI untuk memastikan pelaksanaan edukasi berjalan baik.
Study	- Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan bulan Triwulan I 2025 yaitu 76,98% - Terlihat adanya tren peningkatan dari waktu ke waktu yaitu dari 74,75% pada bulan Januari menjadi 78,95% pada Bulan Maret 2025 - Target 85% belum tercapai - Edukasi dan media edukatif memberikan dampak positif, namun belum cukup signifikan - Analisa Penyebab: - Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO - Belum semua staf mengikuti edukasi Kepatuhan Kebersihan Tangan di Tahun 2025
Action	- Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO. - Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan. - Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI - Memberikan penghargaan kepada individu atau unit kerja dengan tingkat kepatuhan tertinggi. - Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO.	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>) agar mencapai target $\geq 85\%$, guna mencegah infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) dan meningkatkan mutu pelayanan.	Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pelayanan pasien, termasuk dokter, perawat, bidan, analis, dan tenaga pendukung lain.	Memberikan pelatihan ulang tentang pentingnya kebersihan tangan dan implementasi <i>5 Moments</i> WHO secara periodik.	Komite PPI	Satu bulan
2	Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan.	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>)	Seluruh area kerja dan ruang perawatan terdapat media edukasi kebersihan tangan	Pemasangan media edukasi visual seperti poster, banner, atau video di area rawan infeksi.	Komite PPI	Satu bulan

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

3	Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Melakukan observasi langsung terhadap praktik kebersihan tangan dan memberikan umpan balik individual/unit.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Memberikan umpan balik langsung dan bersifat konstruktif kepada tenaga kesehatan.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
5	Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>)	Petugas dengan tingkat kepatuhan rendah	Pembinaan kepada unit dengan kepatuhan rendah.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Triwulan I yakni mencapai 88,12%. Terlihat adanya penurunan pada Bulan Maret 2025 yakni 84,84%. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 88,12%
---------	--

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 88,12%. Bahkan terjadi penurunan pada Bulan Maret Tahun 2025 (84,84%) - Tujuan: Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD menjadi 100% dalam 3 bulan mendatang untuk mencegah infeksi dan menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. - Rencana Aksi: - Edukasi ulang terkait pentingnya penggunaan APD dan jenis-jenis APD sesuai risiko. - Penempatan reminder visual di setiap ruangan tindakan. - Supervisi harian oleh kepala ruangan dan Tim PPI. - Pemantauan ketersediaan APD secara ketat oleh logistik.
Do	- Edukasi dilaksanakan kepada seluruh tenaga kesehatan selama minggu pertama dan kedua. - Poster dan stiker edukasi APD dipasang di ruang perawatan, IGD, laboratorium, dan ruang tindakan. - Tim PPI dan kepala ruangan melakukan inspeksi harian mengenai penggunaan APD. - Koordinasi dilakukan dengan tim logistik untuk menjamin ketersediaan APD tanpa hambatan.
Study	- Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 88,12% - Terjadi penurunan signifikan di Bulan Maret yakni 84,84% - Adapun yang tidak mencapai standar dikarenakan: - Ditemukan perawat yang tidak menggunakan <i>handscoon</i> saat sebelum tindakan ke pasien - Ditemukan perawat yang menggunakan <i>handscoon</i> saat membawa troli dari nurse station setelah tindakan dari pasien (tidak membuang <i>handscoon</i> terlebih dahulu). - Ditemukan petugas laboratorium tidak menggunakan gown di area sampling.
Action	- Membuat sistem “checklist penggunaan APD” yang ditandatangani sebelum dan sesudah tindakan. - Poster dan stiker edukasi APD dipasang di ruang perawatan, IGD, laboratorium, dan ruang tindakan. - Memberikan apresiasi unit dengan kepatuhan terbaik dan laporan per bulan. - Mengkaji kembali kenyamanan APD dan memberi opsi sesuai standar (contoh: masker medis non-iritasi, sarung tangan <i>hypoallergenic</i>).

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

1	Membuat sistem “checklist penggunaan APD” yang ditandatangani sebelum dan sesudah tindakan.	Untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD sesuai standar.	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Sosialisasi penggunaan checklist ke seluruh unit dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan checklist oleh kepala ruangan dan Tim PPI.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
2	Poster dan stiker edukasi APD dipasang di ruang perawatan, IGD, laboratorium, dan ruang tindakan	Memberikan informasi cepat dan jelas terkait tata cara penggunaan APD sesuai standar.	All ruangan	Mendesain media edukasi (poster, stiker atau video) dengan visual menarik, jelas, dan mudah dipahami.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Memberikan apresiasi unit dengan kepatuhan terbaik dan laporan per bulan	Meningkatkan motivasi dan semangat kompetitif antar unit kerja dalam menjaga kepatuhan penggunaan APD.	Unit kerja pelayanan langsung yang menjadi objek audit kepatuhan penggunaan APD	Melakukan audit kepatuhan penggunaan APD secara rutin setiap bulan oleh Tim PPI.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Mengkaji kembali kenyamanan APD dan memberi opsi sesuai standar (contoh: masker medis non-iritasi, sarung tangan <i>hypoallergenic</i>).	Menyediakan pilihan APD yang tetap memenuhi standar keselamatan namun lebih ramah bagi pengguna.	Tenaga kesehatan di semua unit pelayanan yang menggunakan APD secara rutin dan intensif.	Monitoring dan evaluasi	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

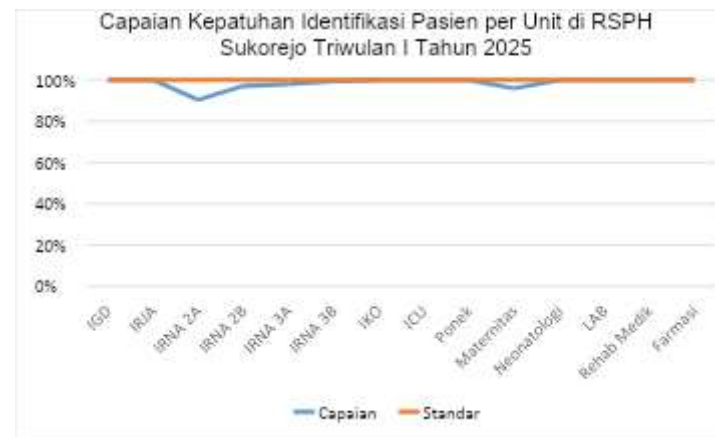
3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Triwulan I Tahun 2025 mencapai 99,24%. Kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menunjukkan tren sangat baik dan stabil. Pada awal periode, capaian berada di angka 98,30%, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 99,76% dan konsisten di atas 99% pada bulan-bulan berikutnya. Puncaknya, pada salah satu bulan, tercatat kepatuhan hampir mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh tenaga kesehatan melakukan identifikasi pasien sesuai standar (menggunakan dua identitas).



Gambar 3.4. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien per unit di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan terdapat 5 unit kepatuhan identifikasi pasien yang tidak mencapai standar yakni Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A) sebesar 90,32%, Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B) sebesar 97,11%, Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) sebesar 98,00%, IRNA 3B 99,55% dan Maternitas sebesar 95,90%. Berdasarkan hasil observasi di Instalasi Rawat Inap 2A dari 310 petugas yang di observasi ditemukan 30 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, yakni 17 petugas yang tidak melakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja dan 13 petugas yang tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan kembali nama pasien, TTL). Adapun di Instalasi Rawat Inap 2B dari 450 petugas yang di observasi ditemukan 13 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, yakni 11 petugas tidak identifikasi secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) tetapi dilakukan secara lisan saja dan dan 2 petugas yang tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan kembali nama pasien, TTL). Adapun di Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) dari 450 petugas yang di observasi ditemukan 9 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja. Adapun di Instalasi Rawat Inap 3B dari 449 petugas yang di observasi ditemukan 2 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat antara etiket dan uji fungsi

pasien) hanya lisan saja. Adapun di Maternitas dari 439 petugas di observasi ditemukan 18 petugas yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan I Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan I Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,24%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 5 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu: 1. IRNA 2A – 90,32% Dari 310 petugas yang diobservasi, 30 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 17 petugas tidak melakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas) b. 13 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) 2. IRNA 2B – 97,11% Dari 450 petugas yang diobservasi, 13 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 11 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) b. 2 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) 3. IRNA 3A – 98,00% Dari 450 petugas yang diobservasi, 9 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 9 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 4. IRNA 3B – 99,55% Dari 450 petugas yang diobservasi, 2 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 2 petugas tidak identifikasi visual (Kekeliruan Pemeriksaan Uji Fungsi Pleura) 5. Maternitas – 95,90% Dari 439 petugas yang diobservasi, 18 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 18 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) Akar Masalah yang teridentifikasi : 1. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP 2. Kurangnya pemahaman pentingnya prosedur identifikasi pasien 3. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual 4. Minimnya pengawasan langsung dari kepala ruangan 2. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Tindak lanjut hasil koordinasi untuk dilakukan pelatihan maupun refresh ulang SPO identifikasi pasien dengan PJ Tim SKP d. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan identifikasi pasien pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 99,24% 2. Sebanyak 5 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu: a. IRNA 2A – 90,32% Dari 310 petugas yang diobservasi, 30 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1. 17 petugas tidak melakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas) 2. 13 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) b. IRNA 2B – 97,11% Dari 450 petugas yang diobservasi, 13 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1. 11 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 2. 2 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) c. IRNA 3A – 98,00% Dari 450 petugas yang diobservasi, 9 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1. 9 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) d. IRNA 3B – 99,55% Dari 450 petugas yang diobservasi, 2 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1. 2 petugas tidak identifikasi visual (Kekeliruan Pemeriksaan Uji Fungsi Pleura) e. Maternitas – 95,90% Dari 439 petugas yang diobservasi, 18 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1. 18 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 3. Adapun yang tidak mencapai standar dikarenakan: a. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP b. Kurangnya pemahaman pentingnya prosedur identifikasi pasien c. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual d. Minimnya pengawasan langsung dari kepala ruangan
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Triwulan I tahun 2025 mencapai 99,24%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pendataan dan rekap nama-nama petugas yang tidak melakukan prosedur identifikasi pasien dengan benar selama proses observasi. 2. Menyusun jadwal koordinasi dengan masing-masing petugas yang teridentifikasi tidak patuh (Koordinasi dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab mutu ruangan, secara individu atau kelompok kecil) 3. Tindak lanjut koordinasi dengan pelatihan dan refresh SPO dengan melibatkan Penanggung Jawab Tim Sasaran Keselamatan Pasien (PJ Tim SKP) 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rekap nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Mengidentifikasi petugas yang tidak menjalankan prosedur dengan benar	Petugas dari all unit pelayanan	Mengolah data observasi, membuat daftar nama & unit	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
2	Penjadwalan koordinasi dengan petugas tidak patuh	Melakukan pendekatan personal dan klarifikasi	Petugas yang terdata tidak patuh	Koordinasi secara individu atau kelompok kecil di ruangan masing - masing	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
3	Refresh training & pembahasan ulang SPO Identifikasi pasien	Memberikan pemahaman ulang terkait prosedur identifikasi dua langkah	Seluruh petugas di unit yang tidak patuh	Edukasi kelompok, diskusi SOP, simulasi sederhana	J Tim SKP, SDM Diklat, Kepala Ruangan	Satu bulan
4	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

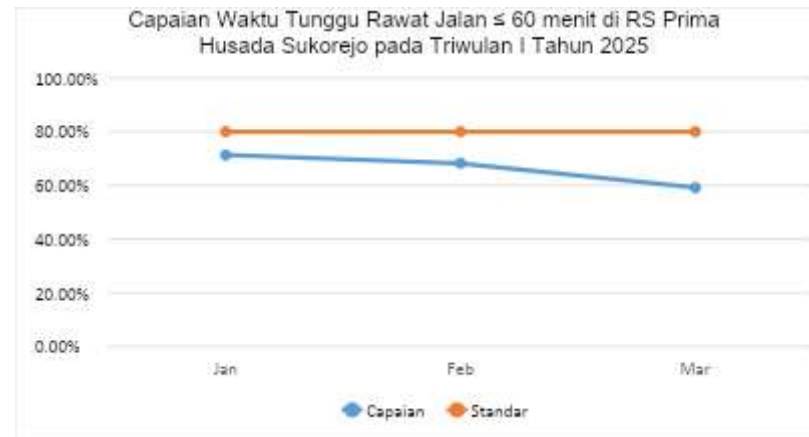


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai standar yakni dengan rata-rata 95,92%. Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dan tindakan kurang dari 30 menit, sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 66,22%. Dari 285 kedatangan pasien yang di observasi ditemukan 99 pasien yang harus menunggu ≥ 60 menit. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 36 menit.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan I Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 66,22% dan belum mencapai target 80%. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan yakni 1 jam 36 menit jauh melebihi standar maksimal 60 menit.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan
Plan	2. Masalah yang ditemukan : Mengurangi waktu tunggu rawat jalan di poli > 60 menit 3. Tujuan : Meningkatkan persentase kepatuhan standar waktu tunggu ≤ 60 menit menjadi minimal 80% pada triwulan berikutnya. 2. Rencana Aksi: 1. Koordinasi dengan dokter agar datang tepat waktu sesuai jadwal praktik. 2. Sosialisasi kepada pasien untuk datang sesuai jadwal dan pentingnya reservasi sebelumnya.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Memonitor waktu kedatangan dokter dan jumlah pasien menumpuk di awal waktu praktik. 2. Melakukan edukasi kepada seluruh petugas front office dan pendaftaran tentang pentingnya efisiensi waktu tunggu.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan Triwulan I yakni 66,22% belum mencapai $\geq 80\%$.

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

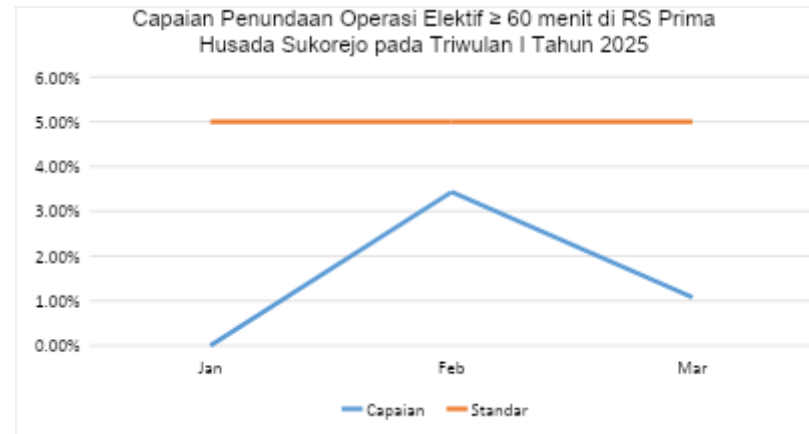
www.rs-primahusada.com

	2. Dari 285 kedatangan pasien yang di observasi ditemukan 99 pasien yang harus menunggu ≥ 60 menit. 3. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 36 menit. Ini dikarenakan: a. Adanya penumpukan pasien di awal jam poli b. Adanya dokter yang terlambat dari jadwal praktik
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit yakni 66,22% belum mencapai $\geq 80\%$. Rata-rata keterlambatan terjadi dalam waktu 1 jam 36 menit. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan dokter agar datang tepat waktu sesuai jadwal praktik. 2. Sosialisasi kepada pasien untuk datang sesuai jadwal dan pentingnya reservasi sebelumnya.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan dokter agar datang tepat waktu sesuai jadwal praktik	Mengurangi waktu tunggu awal poli	Dokter Poli Rawat Jalan	Rapat koordinasi dengan Kabid Pelayanan & Komite Medik	Kabid Pelayanan & Komite Medik	Satu bulan
2	Sosialisasi kepada pasien untuk datang sesuai jadwal dan pentingnya reservasi sebelumnya	Meningkatkan efisiensi dan pelayanan awal	CSO, Pendaftaran & Poli Rawat Jalan	Pelatihan petugas Pendaftaran, CSO, dan Perawat Poli	SDM Diklat, Komite Medik, Komite Mutu	Satu bulan

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

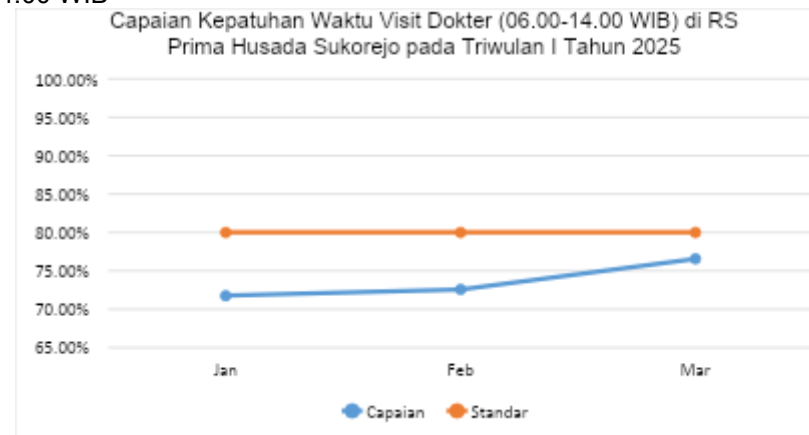


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I tahun 2025 yakni 1,5%. Capaian ini sudah mencapai standar < 5 %.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap mencapai 73,63% dan masih dibawah standar $\geq 80\%$. Adanya tren meningkat dari Bulan Januari ke Bulan Maret 2025 tapi masih perlu perbaikan untuk mencapai target mutu.

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

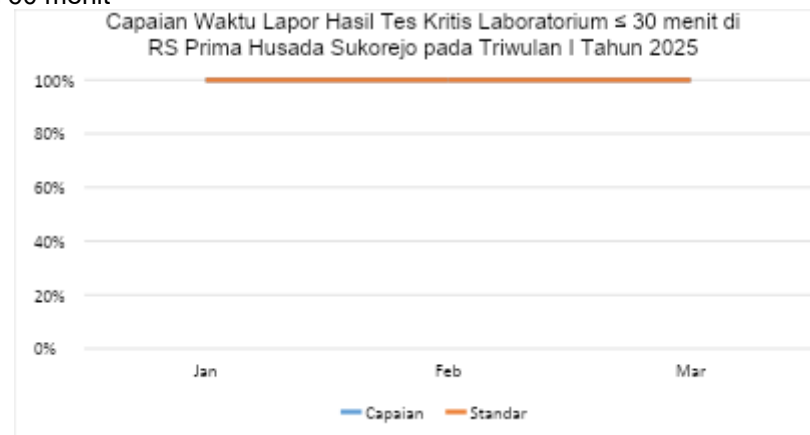
Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 adalah 73,63 belum mencapai target $\geq 80\%$
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	3. Identifikasi Masalah : 1. Capaian kepatuhan waktu visit dokter spesialis masih di bawah standar (rata-rata triwulan I: 73,63%) 2. Masih ditemukan dokter yang tidak melakukan visit rutin, tidak ada bukti dokumentasi di rekam medis. 3. Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. 4. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif). Tujuan : 1. Meningkatkan kepatuhan visit dokter menjadi minimal 80%. Rencana Aksi: 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat).
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? 1. Pelaksanaan Visit Rutin Sesuai Jam yang Ditentukan (Pagi ≤ 14.00 WIB) 2. Waktu visit dicatat dalam rekam medis dan checklist visit. 3. DPJP mengisi form/checklist visit dengan tanda tangan/paraf sebagai bukti kunjungan.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 73,63%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini dikarenakan: 1. Masih ditemukan dokter yang tidak melakukan visit rutin, tidak ada bukti dokumentasi di rekam medis. 2. Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB 3. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif).
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 73,63%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat).

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

1	Audit harian oleh kepala ruangan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang datang $\geq$ 14.00	Rapat koordinasi dengan komite medik	Kepala Ruang	Satu bulan
2	Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Seluruh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di rumah sakit	Rapat Koordinasi dengan SDM	Komite Medik & SDM	Satu bulan
3	Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat)	Menjamin kontinuitas pelayanan medis melalui penggantian DPJP saat cuti	Dokter Penanggung jawab Pasien	Menetapkan DPJP pengganti resmi saat dokter cuti, dan mendokumentasikannya secara formal.	Kepala Bidang Pelayanan	Satu bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 60 menit

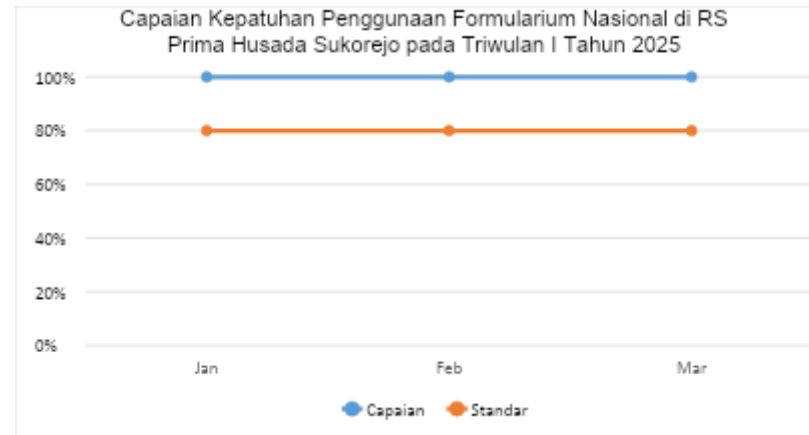


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari 983 hasil kritis laboratorium di observasi, 983 hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

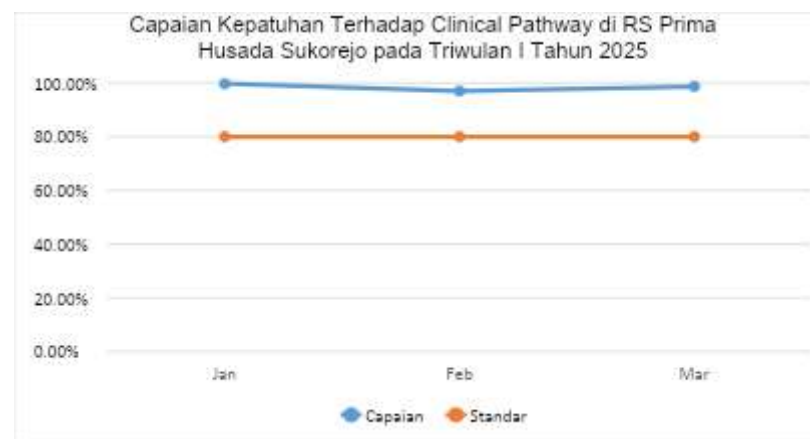


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan persepsan obat hanya dari Formularium Nasional.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

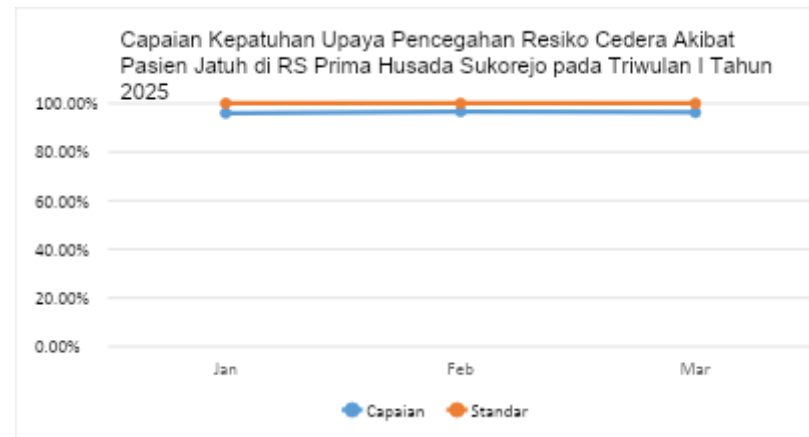


Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Triwulan I Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 98,46%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway bulan Triwulan I didapatkan dari diagnosa Pneumonia, PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Triwulan I tahun 2025 adalah 96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 4923 petugas yang di observasi ditemukan 183 petugas tidak patuh dari pencegahan resiko jatuh.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

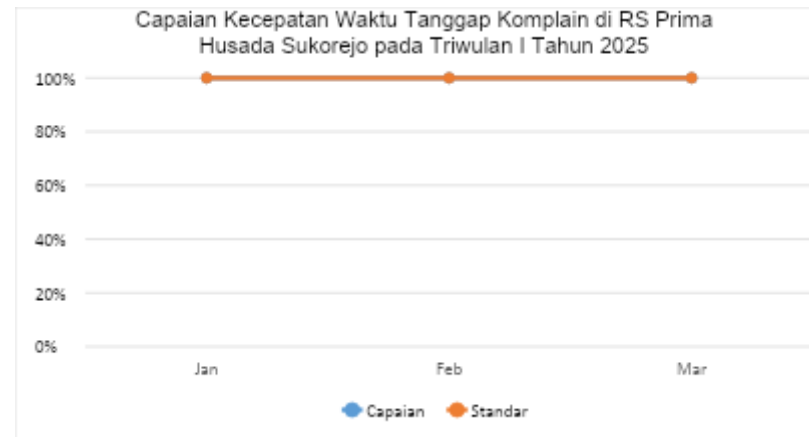
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Identifikasi Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 96,28% 2. Ketidaksesuaian antara SPO dan penerapan petugas terkait Pencegahan Resiko Jatuh 3. Tanda resiko jatuh tidak terpasang di kursi roda 4. Hand rail hanya terpasang di salah satu bed pasien Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Koordinasi dengan kepala ruangan dan Tim SKP untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko jatuh

	2. Pelatihan oleh Tim SKP terkait perhitungan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Ketidaksesuaian antara SPO dan penerapan petugas terkait Pencegahan Resiko Jatuh 2. Tanda resiko jatuh tidak terpasang di kursi roda 3. Hand rail hanya terpasang di salah satu bed pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan I Tahun 2025 belum sesuai standar yakni Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruangan dan Tim SKP untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko jatuh 2. Pelatihan oleh Tim SKP terkait perhitungan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala ruangan dan Tim SKP untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko jatuh	Mengurangi ketidakpatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Seluruh staff yang tidak patuh dalam upaya resiko jatuh dapat ditindak lanjuti oleh Tim SKP	Koordinasi dengan Tim SKP	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Pelatihan oleh Tim SKP terkait perhitungan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang	Mengurangi ketidakpatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Seluruh staff yang tidak patuh memiliki pengetahuan yang meningkat dan kepatuhan 100%	Pelatihan dengan menggunakan uji coba praktek langsung perhitungan cara skrinning awal dan skrinning ulang resiko jatuh	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

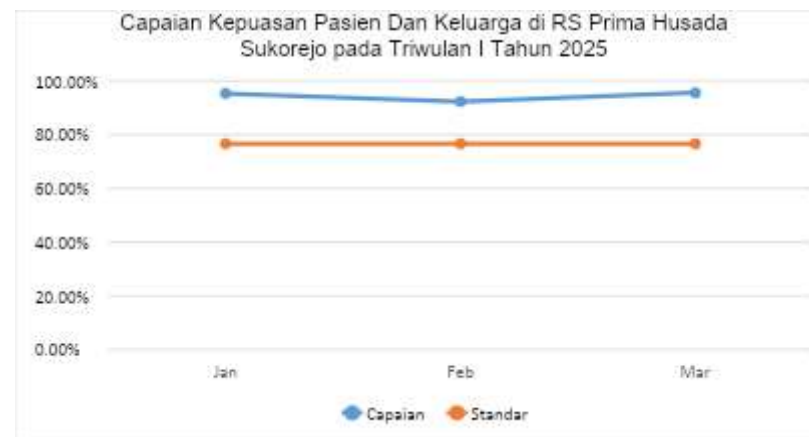


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan I Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

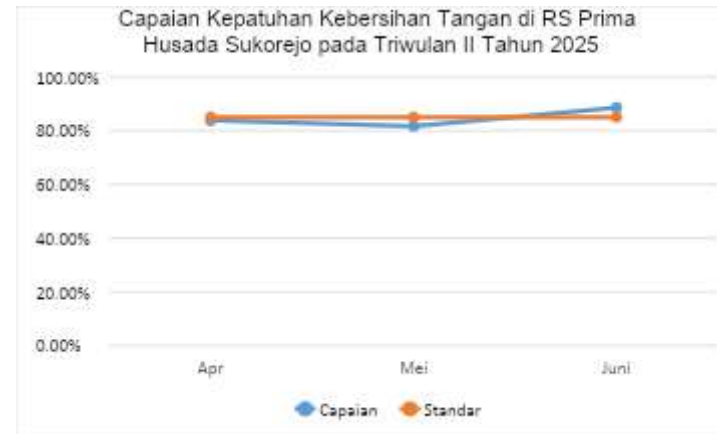
Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 94,41%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

Berikut merupakan tabel capaian Indikator Mutu Nasional (IMN) Triwulan II di RS Prima Husada Sukorejo

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		April	Mei	Juni			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80%	81,66%	88,59%	≥85%	84,68%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	97,92%	98,07%	93,83%	100%	96,61%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,65%	99,73%	98,97%	100%	99,45%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	96,77%	85,71%	100%	≥80%	94,16%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	74,78%	70,14%	79,70%	≥80%	74,87%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	4,52%	1,37%	3,84%	≤5%	3,24%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	71,19%	74,97%	77,96%	≥80%	74,71%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	98,44%	98,84%	98,75%	≥80%	98,68%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	97,44%	97,99%	98,75%	100%	98,06%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30%	≥76.61%	96,10%	Dipertahankan

Analisis Hasil Capaian Indikator Mutu Nasional (IMN) Triwulan II di RS Prima Husada Sukorejo

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II (April–Juni), diperoleh rata-rata sebesar 84,68%. Pada bulan April, tingkat kepatuhan mencapai 83,80%, kemudian menurun menjadi 81,66% di bulan Mei, dan meningkat signifikan menjadi 88,59% di bulan Juni. Meskipun nilai masih berada di atas 80%, capaian belum memenuhi standar ideal kepatuhan kebersihan tangan WHO yaitu $\geq 85\%$. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan II Tahun 2025

Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II 2025 hanya mencapai 84,68%, belum mencapai target $\geq 85\%$.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan saat ini sebesar 84,68%. - Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. - Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. - Tujuan:

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

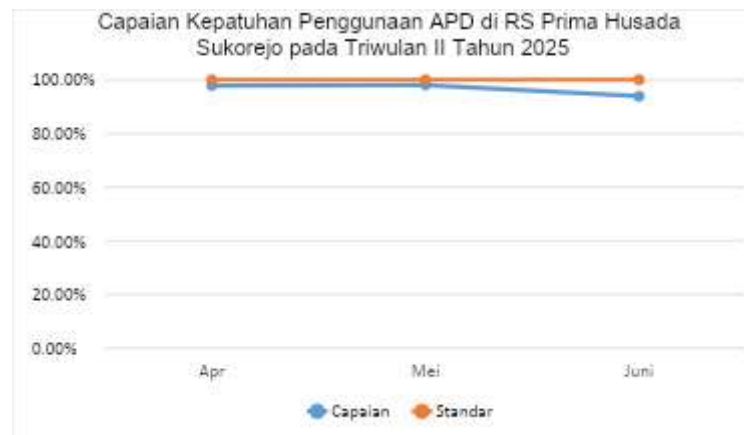
	a. Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan $\geq 85\%$ secara konsisten selama Triwulan III (Juli–September 2025). b. Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan 3. Rencana Aksi: a. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). b. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. c. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	1. IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu 2. Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. 3. Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	1. Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan II 2025 yaitu 84,68% 2. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan $\geq 85\%$ adalah IRNA 3A sebesar 84,68%. 3. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 90,43% walaupun belum mencapai standar 4. Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO 5. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan a. Sebelum kontak dengan pasien sebesar 56,40% b. Sebelum Tindakan aseptik sebesar 49,07% c. Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 58,37% d. Setelah kontak dengan pasien sebesar 64,88% e. Setelah dari lingkungan pasien sebesar 54,53%
Action	1. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). 2. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. 3. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan bedside coaching	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentasi hasil audit untuk evaluasi	IPCN/IPCLN	1 kali/minggu/unit (Juli–Sept 2025)
2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan

				- Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen		
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (Juli–Des 2025)

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Triwulan II yakni mencapai 96,61% masih belum mencapai target 100% yang telah ditetapkan sebagai standar rumah sakit. Capaian tertinggi terjadi pada bulan Mei 98,07%. Capaian terendah terjadi pada bulan Juni 93,83%. Terdapat tren penurunan dari Bulan Mei ke Juni sebesar 4,24%

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 96,61%. Meskipun pelatihan penggunaan APD telah dilaksanakan pada bulan Mei (untuk seluruh staf) dan diperkuat kembali dalam pelatihan PMKP bulan Juni (khusus CS dan Unit Umum), tingkat kepatuhan penggunaan APD masih belum mencapai target 100%.
---------	--

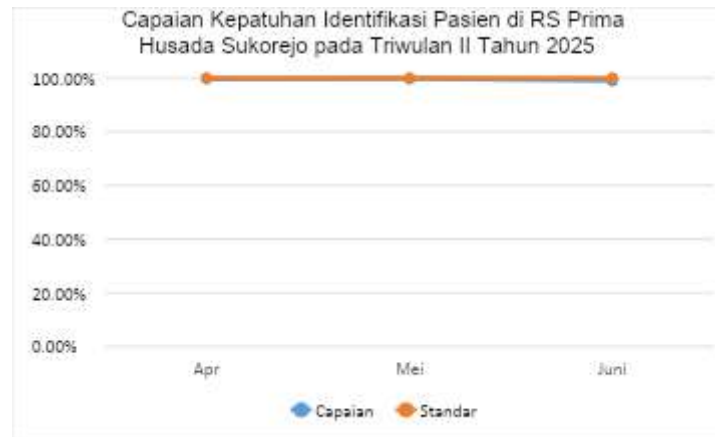
Step	Melakukan penguatan edukasi berkelanjutan dan monitoring langsung kepada seluruh staf, khususnya kepada kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan (CS dan Unit Umum), serta mempersiapkan strategi intervensi berikutnya untuk staf penunjang dan pelayanan melalui pelatihan terjadwal di bulan Juli 2025.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 96,61%. - Setelah dua kali pelatihan (umum dan khusus), masih ditemukan staf (terutama CS dan non-medis) yang belum konsisten dalam penggunaan APD sesuai prosedur. - Rencana pelatihan berikutnya untuk staf penunjang dan pelayanan akan dilakukan pada bulan Juli 2025. - Tujuan: - Meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD hingga mencapai 100%, khususnya pada unit yang telah mendapatkan pelatihan. - Mempersiapkan intervensi lanjutan untuk unit yang akan mengikuti pelatihan di bulan Juli (penunjang dan pelayanan). - Rencana Aksi: - Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai tindak lanjut pelatihan. - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. - Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian. - Merancang pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan di bulan Juli, dengan pendekatan berbasis kasus.
Do	- Melakukan observasi langsung terhadap penggunaan APD staf CS dan Unit Umum pasca pelatihan - Memberikan feedback dan pembinaan langsung kepada staf yang ditemukan tidak sesuai prosedur. - Menyusun materi pelatihan berbasis risiko kerja untuk unit penunjang (Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Gizi) dan pelayanan (IGD, Rawat Inap, OK) sebagai persiapan pelatihan Juli.
Study	- Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 96,61% belum mencapai target 100% - Ketidaksesuaian ditemukan terutama pada: - Petugas CS masih ditemukan menggunakan satu sarung tangan saat membuang limbah ke TPS. - Perawat masih menggunakan handscoon di luar prosedur, misalnya saat membawa troli dari nurse station ke ruang pasien. - Beberapa petugas CS tidak memakai sarung tangan saat mengambil sampah di unit pelayanan. - Petugas laboratorium tidak mengenakan gown saat pengambilan sampel, meskipun berada di area berisiko. - Perawat tidak menggunakan APD lengkap saat melakukan tindakan aseptik, seperti pemasangan infus atau perawatan luka. - Monitoring menunjukkan unit yang mendapat pelatihan (CS & Umum) lebih aware, namun perubahan perilaku belum konsisten. - Evaluasi pelatihan menunjukkan perlunya penguatan praktik langsung dan coaching on the spot, bukan hanya teori.
Action	- Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai tindak lanjut pelatihan. - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. - Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian. - Merancang pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan di bulan Juli, dengan pendekatan berbasis kasus

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

1	Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN	Mendeteksi dini ketidakpatuhan dan memberikan pembinaan langsung	Seluruh unit pelayanan, penunjang, CS, dan Unit Umum	• Observasi langsung • Pembinaan di tempat (real-time coaching) • Dokumentasi dan tindak lanjut langsung	IPCN, IPCLN	Juli
2	Audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum	Menindaklanjuti hasil pelatihan Juni dan memperkuat penerapan di lapangan	Petugas CS dan Unit Umum	• Audit mingguan • Supervisi oleh IPC dan Karu • Penguatan budaya kerja aman	IPCN, Karu, Supervisor CS, Koordinator Unit Umum	Juli
3	Penyusunan dan distribusi SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan Non-Medis	Menyediakan panduan praktis dan mudah dipahami di area kerja	Bidang Umum, (CS, Keamanan, Gudang, Sopir)	• SPO 1 lembar disesuaikan dengan risiko kerja • Poster visual dipasang di area kerja • Sosialisasi singkat per shift	Tim IPC, Tim PMKP, Kepala Unit	Juli
4	Peningkatan peran Karu dan supervisor dalam monitoring harian	Memastikan keberlanjutan kepatuhan di level unit	Seluruh unit pelayanan, penunjang, dan umum	• Format pelaporan ketidaksesuaian harian • Peningat briefing harian • Koordinasi antar shift	Kepala Ruang	Juli
5	Pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan berbasis kasus	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan penggunaan APD berdasarkan situasi kerja	Petugas laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, rawat inap, IGD	• Pelatihan berbasis studi kasus nyata • Diskusi interaktif • Simulasi langsung	Tim Diklat, IPCN/IPCLN, PMKP, Komite PPI	Juli

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II 2025 mencapai 99,45%. Dari 18698 petugas yang diidentifikasi, 18594 petugas patuh terhadap Identifikasi pasien sedangkan 104 petugas tidak patuh dalam identifikasi pasien. Capaian 99,45% menunjukkan komitmen tinggi tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien, khususnya identifikasi pasien dengan dua identitas sebelum tindakan. Namun, capaian ini belum mencapai target standar 100%, sehingga tetap perlu perhatian dan perbaikan. Capaian tertinggi yakni di Bulan Mei (99,70%) dan capaian terendah yakni di Bulan Juni (98,97%), Sebanyak 104 kejadian ketidakpatuhan tercatat. Meski terlihat kecil secara persentase, setiap insiden ketidakpatuhan dapat berdampak serius, termasuk risiko tertukarnya identitas pasien dan kesalahan pemberian tindakan atau obat

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan II Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,45%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : 1. Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponek 2. Kepatuhan identifikasi pasien selama Triwulan II menunjukkan penurunan pada bulan Juni, meskipun telah dilakukan pelatihan PMKP untuk staf unit umum pada bulan tersebut. Nilai kepatuhan belum mencapai standar maksimal 100%. Akar Masalah yang teridentifikasi : 1. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP 2. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

	3. Petugas non-medis (umum) mulai menunjukkan peningkatan kesadaran pasca pelatihan, namun belum diikuti oleh bagian pelayanan dan penunjang. 4. Sosialisasi hasil pelatihan belum menjangkau seluruh staf karena keterbatasan waktu dan rotasi. 2. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : a. Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 b. Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh IPCN dan Tim Mutu untuk memantau dampak pelatihan. c. Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum. d. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponek 2. Capaian bulan April–Mei relatif tinggi dan stabil. 3. Capaian bulan Juni menurun menjadi 98,97% karena: a. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual di Rawat Inap b. Perubahan kebiasaan memerlukan waktu untuk tertanam, terutama pada petugas baru dan unit dengan beban tinggi
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 99,45%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 2. Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan. 3. Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum. 4. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025	Meningkatkan pemahaman dan implementasi identifikasi pasien yang benar sesuai standar akreditasi	Petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, laboratorium, radiologi, farmasi, dll)	Pelatihan tatap muka atau daring, disertai simulasi kasus dan roleplay	Tim PMKP, IPCN/IPCLN, Komite Keperawatan/Medis, SDM	Bulan Juli
2	Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan	Menilai dampak pelatihan terhadap praktik identifikasi pasien di lapangan	Unit pelayanan dan penunjang pasca pelatihan	Observasi langsung, audit checklist, wawancara petugas	Tim Mutu, Tim SKO Karu/	Bulan Juli, Agustus, September

3	Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum.	Menyediakan panduan praktis yang mudah diakses dan dipahami oleh petugas	Petugas umum, pelayanan, dan penunjang	Cetak SPO ringkas dan pasang di titik strategis (nurse station, ruang tindakan, dll)	SKP, Kepala Unit	Bulan Juli
4	Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli	Menjamin kesiapan teknis pelatihan agar berjalan efektif dan tepat sasaran	Seluruh peserta dari unit pelayanan dan penunjang	Identifikasi peserta, pembuatan materi, jadwal, dan undangan	Tim PMKP, SDM, Kepala Unit masing-masing	Bulan Juli

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

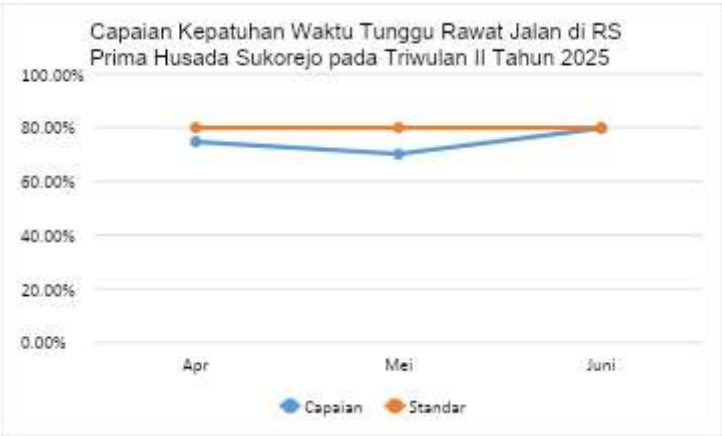


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar yakni dengan rata-rata 94,16%. Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dan tindakan kurang dari 30 menit, sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025 mecapai 74,87%. Nilai ini masih berada di bawah standar yang ditetapkan, yaitu ≥80%. Capaian terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 70,14%, sementara capaian tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 79,70%. Meskipun terdapat perbaikan pada bulan Juni, hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan belum sepenuhnya memenuhi target mutu, sehingga diperlukan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan dalam sistem dan proses pelayanan.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan II Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 74,87% dan belum mencapai target 80%. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan yakni 1 jam 09 menit jauh melebihi standar 60 menit.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan
Plan	2. Masalah yang ditemukan : Rata-rata waktu tunggu rawat jalan masih tinggi, yakni 1 jam 09 menit, dengan tingkat kepatuhan terhadap standar waktu tunggu ≤ 60 menit hanya sebesar 74,87%. 3. Tujuan :

	4. Meningkatkan persentase kepatuhan standar waktu tunggu ≤ 60 menit menjadi minimal 80% pada triwulan berikutnya. 2. Rencana Aksi: 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Memonitor waktu kedatangan dokter dan jumlah pasien menumpuk di awal waktu praktik. 2. Melakukan edukasi kepada seluruh petugas front office dan pendaftaran tentang pentingnya efisiensi waktu tunggu.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan Bulan Triwulan II yakni 74,87% belum mencapai $\geq 80\%$. 2. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 09 menit. Ini dikarenakan: a. Penumpukan Pasien di Awal Jam Poli b. Beberapa dokter spesialis tidak datang tepat waktu sesuai jadwal praktik yang telah ditentukan,
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit yakni 74,87% belum mencapai $\geq 80\%$. Rata-rata keterlambatan terjadi dalam waktu 1 jam 09 menit. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penjadwalan ulang atau pembagian tugas pasien di poli untuk DPJP	Meningkatkan pemerataan pasien per DPJP dan mengurangi waktu tunggu	Pasien rawat jalan di poli spesialis	• Review kuota pasien per DPJP • Penjadwalan slot waktu per dokter	Komite Medik, Koordinator Poli	Satu bulan
2	Monitoring kedatangan dokter dan evaluasi disiplin waktu praktik	Mengurangi waktu tunggu awal poli	Dokter Poli Rawat Jalan	Rapat koordinasi dengan Kabid Pelayanan & Komite Medik	Kabid Pelayanan & Komite Medik	Satu bulan
3	Edukasi pasien untuk datang sesuai jadwal melalui call center/pendaftaran online	Meningkatkan kedisiplinan waktu kedatangan pasien sesuai slot waktu	Pasien rawat jalan	• Petugas call center memberi reminder jam kedatangan saat reservasi • Edukasi saat konfirmasi jadwal online	Pendaftaran & CSO	Satu bulan

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

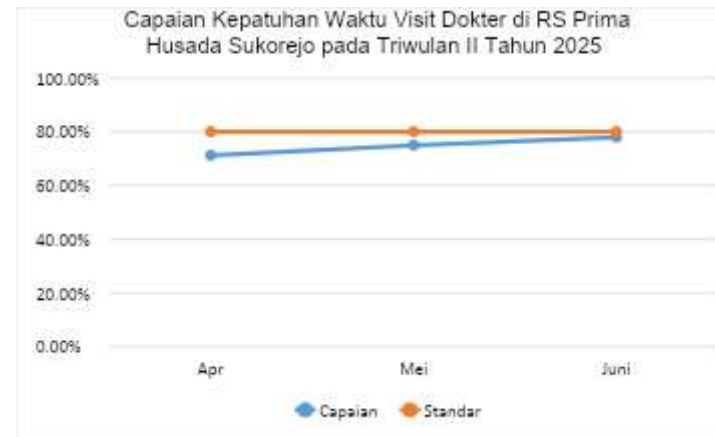


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II tahun 2025 yakni 3,24%. Capaian ini sudah mencapai standar $<5\%$.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap mencapai 74,71% dan masih dibawah standar $\geq 80\%$. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah dokter spesialis yang belum melakukan visite pasien secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan medis, pelaksanaan terapi, dan perencanaan pemulangan pasien.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Triwulan II Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 74,71% belum mencapai target $\geq 80\%$
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	3. Identifikasi Masalah : 1. Capaian kepatuhan waktu visit dokter spesialis masih di bawah standar (rata-rata Bulan Triwulan II yakni 74,71%. 2. Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. 3. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif). Tujuan : 1. Meningkatkan kepatuhan visit dokter menjadi minimal 80%. Rencana Aksi: 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis
Do	Apa pengamatan yang dilakukan?

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

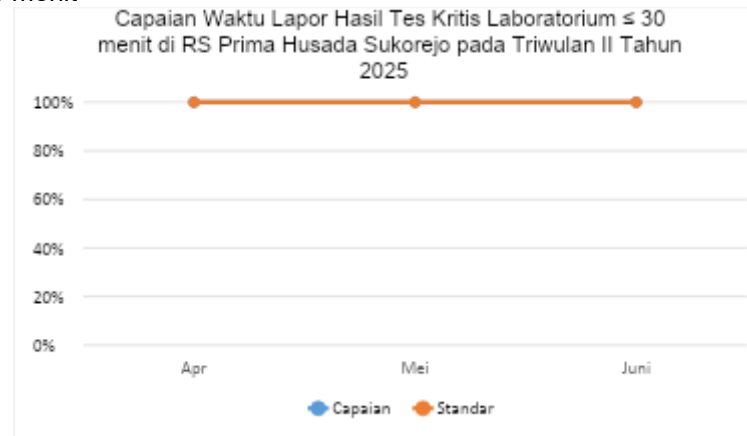
	1. Pelaksanaan Visit Rutin Sesuai Jam yang Ditentukan (Pagi ≤ 14.00 WIB) 2. Waktu visit dicatat dalam rekam medis dan checklist visit. 3. DPJP mengisi form/checklist visit dengan tanda tangan/paraf sebagai bukti kunjungan.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 74,71%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai ≥ 80%. Ini dikarenakan: 1. Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB 2. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif). 3. Adanya Pasien yang berada di ICU sebagian besar mengalami kondisi terminal sehingga pasien tersebut berada dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan segera.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 74,71%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai ≥ 80%. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit harian oleh kepala ruangan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang datang ≥ 14.00	Rapat koordinasi dengan komite medik	Kepala Ruang	Satu bulan
2	Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Seluruh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di rumah sakit	Rapat Koordinasi dengan SDM	Komite Medik & SDM	Satu bulan
3	Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat)	Menjamin kontinuitas pelayanan medis melalui penggantian DPJP saat cuti	Dokter Penanggung jawab Pasien	Menetapkan DPJP pengganti resmi saat dokter cuti, dan mendokumentasikannya secara formal.	Kepala Bidang Pelayanan	Satu bulan
4	Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada pasien rawat inap khususnya pasien kritis di ICU	Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan pasien kritis yang dirawat di ICU	Menyusun daftar harian pasien kritis yang membutuhkan prioritas visite.	Kepala Ruang ICU, DPJP, Komite Medi	Satu bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
		melalui sistem koordinasi dan prioritas yang lebih baik.		Melaksanakan koordinasi pagi antara perawat ICU dan DPJP sebelum jam visite		

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 60 menit

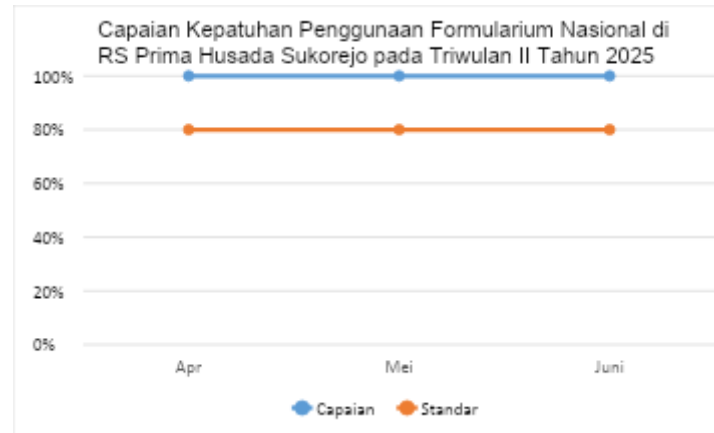


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

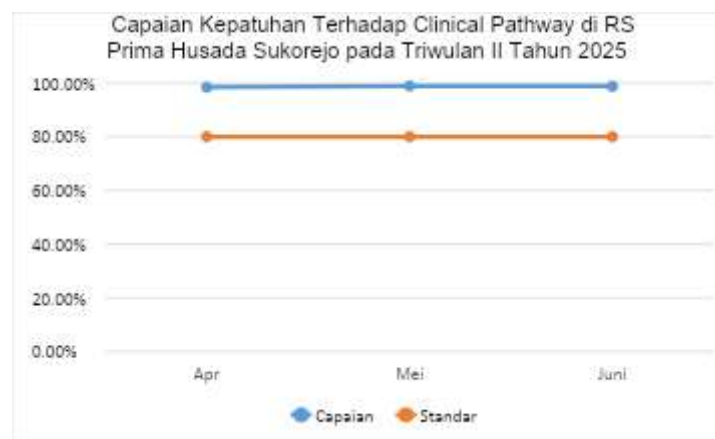


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Dari formularium nasional yang diobservasi, Seluruh resep yang diberikan oleh Unit Farmasi menggunakan obat yang termasuk dalam Formularium Nasional (Fornas). Capaian 100% menunjukkan bahwa tidak ada peresepan obat di luar Fornas, sehingga risiko penggunaan obat tidak sesuai standar dapat ditekan.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)



Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Bulan Triwulan II Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 98,68%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan Triwulan II didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan II tahun 2025 adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Terdapat tren peningkatan capaian dari bulan ke bulan, yaitu dari 97,44% (April) menjadi 98,75% (Juni). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kepatuhan secara bertahap selama triwulan berjalan.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan II Tahun 2025adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% - Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni 2025, belum seluruh petugas di unit pelayanan dan penunjang terpapar materi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi :

	1. Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 2. Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. 3. Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. 4. Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrining awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrining ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% 2. Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). 3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak terempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan II Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,06% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 2. Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. 3. Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. 4. Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan staf dalam pencegahan risiko jatuh	Seluruh petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, lab, radiologi, farmasi, rehab medik, dll)	Pelatihan klasikal dan simulasi lapangan terkait skrining dan tindakan pencegahan risiko jatuh	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala Ruang	Juli
2	Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami	Menyederhanakan panduan agar mudah diikuti dan konsisten diterapkan di semua unit	Seluruh petugas yang mengisi skrining risiko jatuh	Meninjau SPO lama dan menyusun ulang SPO singkat berbasis praktik terbaik dan hasil audit	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala Ruang	Juli

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

3	Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien	Meningkatkan kesadaran petugas dan keluarga pasien tentang pencegahan risiko jatuh	Seluruh pasien rawat inap dan petugas di ruang perawatan	Pemasangan stiker/peringatan visual pada dinding/tempat tidur pasien dengan risiko jatuh	Kepala Unit	Juli
4	Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentas	Meningkatkan identifikasi pasien risiko tinggi dan memastikan dokumentasi lengkap	Pasien dengan risiko jatuh dan petugas yang melakukan penilaian risiko	Distribusi label risiko jatuh & audit checklist kelengkapan form risiko jatuh	Kepala Unit	Juli

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain



Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan II Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 96,10%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada bulan Triwulan II, capaian tetap berada jauh di atas standar, yang menunjukkan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Berikut merupakan tabel capaian Indikator Mutu Nasional (IMN) Triwulan III di RS Prima Husada Sukorejo

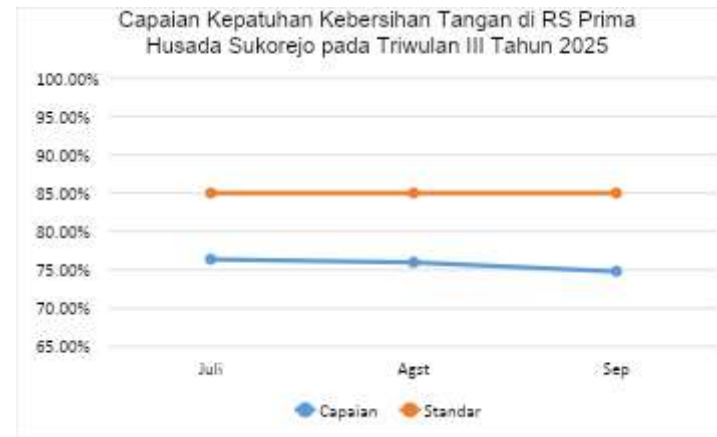
No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		Juli	Agustus	September			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	76,39%	75,98%	74,81%	≥85%	75,73%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		Juli	Agustus	September			
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	92,01%	83,84%	83,55%	100%	86,47%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,80%	99,56%	99,68%	100%	99,68%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi $\leq$ 30 menit	100%	97,30%	100%	$\geq$ 80%	99,10%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan $\leq$ 60 menit	64,29%	77,96%	61,67%	$\geq$ 80%	67,97%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif $\geq$ 60 menit	3,68%	3,98%	2,36%	$\leq$ 5%	3,34%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	80,09%	77,28%	76,10%	$\geq$ 80%	77,82%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	$\geq$ 80%	100%	Dipertahankan
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,19%	98,99%	100%	$\geq$ 80%	99,39%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	98,63%	97,68%	98,55%	100%	98,29%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	$\geq$ 80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	95,00%	88,10%	93,10%	$\geq$ 76.61%	92,07%	Dipertahankan

Analisis Hasil Capaian Indikator Mutu Nasional (IMN) Triwulan III di RS Prima Husada Sukorejo

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan III yakni mencapai 75,73%. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu $\geq 85\%$. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Bulan Triwulan III 2025 hanya mencapai 75,73%, belum mencapai target $\geq 85\%$.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan bulan Triwulan III 2025 sebesar 75,73%. - Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. - Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. - Tujuan: - Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan $\geq 85\%$ secara konsisten selama Triwulan III (Juli – September 2025). - Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan - Rencana Aksi: - Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>).

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

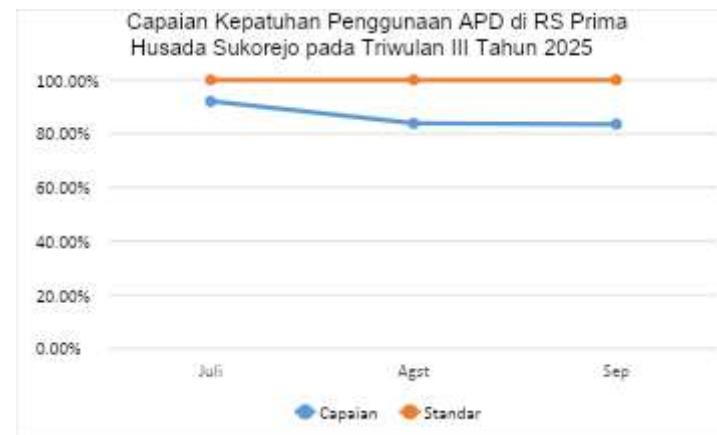
	b. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. c. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	1. IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu 2. Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. 3. Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	1. Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan III 2025 yaitu 75,73% 2. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan tertinggi yakni unit Farmasi sebesar 100% 3. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 85,19% walaupun belum mencapai standar 4. Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO 5. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan a. Sebelum kontak dengan pasien sebesar 58,43% b. Sebelum Tindakan aseptik sebesar 65,98% c. Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 67% d. Setelah kontak dengan pasien sebesar 66,10% e. Setelah dari lingkungan pasien sebesar 67,23%
Action	1. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). 2. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. 3. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan bedside coaching	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentasi hasil audit untuk evaluasi	IPCN/IPCLN	1 kali/minggu/unit
2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan

				- Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen		
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (September–Des 2025)

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Triwulan III yakni mencapai 86,47%. Terjadi penurunan signifikan 8% dari bulan Agustus ke Bulan Juli Tahun 2025. Tetap hasil capaian di bulan september hampir sama dengan bulan Agustus 2025. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan penggunaan APD masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 86,47%. Meskipun pelatihan penggunaan APD telah dilaksanakan pada bulan Mei (untuk Pelatihan PPI seluruh staf) dan diperkuat kembali dalam pelatihan PMKP bulan Juni dan Triwulan III, tingkat kepatuhan penggunaan APD masih belum mencapai target 100%.
Step	Melakukan penguatan edukasi berkelanjutan dan monitoring langsung kepada seluruh staf, khususnya kepada kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 86,47%. - Setelah dua kali pelatihan (umum dan khusus), masih ditemukan staf yang belum konsisten dalam penggunaan APD sesuai prosedur. - Tujuan: - Meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD hingga mencapai 100%, khususnya pada unit yang telah mendapatkan pelatihan. - Rencana Aksi: - Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai tindak lanjut pelatihan. - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. - Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian.
Do	- Melakukan observasi langsung terhadap penggunaan APD staf CS dan Unit Umum pasca pelatihan - Memberikan feedback dan pembinaan langsung kepada staf yang ditemukan tidak sesuai prosedur.
Study	- Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 86,47% belum mencapai target 100% - Monitoring menunjukkan unit yang mendapat pelatihan lebih aware, namun perubahan perilaku belum konsisten. - Evaluasi pelatihan menunjukkan perlunya penguatan praktik langsung dan coaching on the spot, bukan hanya teori.
Action	- Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf sebagai tindak lanjut pelatihan. - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. - Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian.

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN	Mendeteksi dini ketidakpatuhan dan memberikan pembinaan langsung	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	- Observasi langsung - Pembinaan di tempat (real-time coaching)	IPCN, IPCLN	1 Bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
				Dokumentasi dan tindak lanjut langsung		
2	Audit dan supervisi khusus bagi staf yang sudah mendapatkan pelatihan	Menindaklanjuti hasil pelatihan Juni, Triwulan III dan memperkuat penerapan di lapangan	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	- Audit mingguan - Supervisi oleh IPC dan Karu - Penguatan budaya kerja aman	IPCN, Karu, Supervisor CS, Koordinator Unit Umum	1 Bulan
3	Penyusunan dan distribusi SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan Non-Medis	Menyediakan panduan praktis dan mudah dipahami di area kerja	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	- SPO 1 lembar disesuaikan dengan risiko kerja - Poster visual dipasang di area kerja - Sosialisasi singkat per shift	Tim IPC, Tim PMKP, Kepala Unit	1 Bulan
4	Peningkatan peran Karu dan supervisor dalam monitoring harian	Memastikan keberlanjutan kepatuhan di level unit	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	- Format pelaporan ketidaksesuaian harian - Pengingat briefing harian - Koordinasi antar shift	Kepala Ruang	1 Bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III 2025 mencapai 99,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan III Tahun 2025

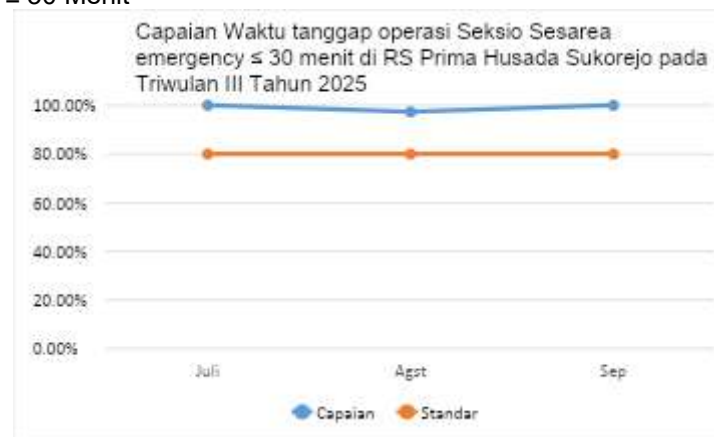
Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan III Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,68%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi. Akar Masalah yang teridentifikasi: 1. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP 2. Proses identifikasi tidak dilakukan menyeluruh (hanya tanya nama tanpa verifikasi gelang/etiket). 3. Tidak semua unit konsisten dalam pelaksanaan audit internal. 2. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Tindak lanjut hasil koordinasi untuk dilakukan pelatihan maupun refresh ulang SPO identifikasi pasien dengan PJ Tim SKP d. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan III tahun 2025 mencapai 99,68%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan

1. Melakukan pendataan dan rekap nama-nama petugas yang tidak melakukan prosedur identifikasi pasien dengan benar selama proses observasi.
2. Menyusun jadwal koordinasi dengan masing-masing petugas yang teridentifikasi tidak patuh (Koordinasi dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab mutu ruangan, secara individu atau kelompok kecil)
3. Tindak lanjut koordinasi dengan pelatihan dan refresh SPO dengan melibatkan Penanggung Jawab Tim Sasaran Keselamatan Pasien (PJ Tim SKP)
4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rekap nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Mengidentifikasi petugas yang tidak menjalankan prosedur dengan benar	Petugas dari all unit pelayanan	Mengolah data observasi, membuat daftar nama & unit	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
2	Penjadwalan koordinasi dengan petugas tidak patuh	Melakukan pendekatan personal dan klarifikasi	Petugas yang terdata tidak patuh	Koordinasi secara individu atau kelompok kecil di ruangan masing - masing	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
3	Refresh training & pembahasan ulang SPO Identifikasi pasien	Memberikan pemahaman ulang terkait prosedur identifikasi dua langkah	Seluruh petugas di unit yang tidak patuh	Edukasi kelompok, diskusi SOP, simulasi sederhana	J Tim SKP, SDM Diklat, Kepala Ruangan	Satu bulan
4	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

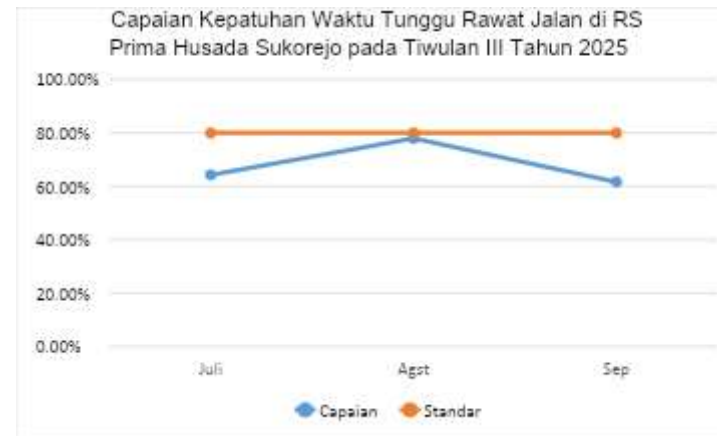


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 99,10%. Dari 103 pasien yang diobservasi, 1 pasien yang mendapatkan pelayanan tanggap SC Emergency lebih dari 60 menit. Secara keseluruhan Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan $\leq$ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan $\leq$ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 mecapai 67,97%. Capaian pada bulan September adalah yang **terendah** dari periode tiga bulan ini.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan $\leq$ 60 menit pada Triwulan III Tahun 2025

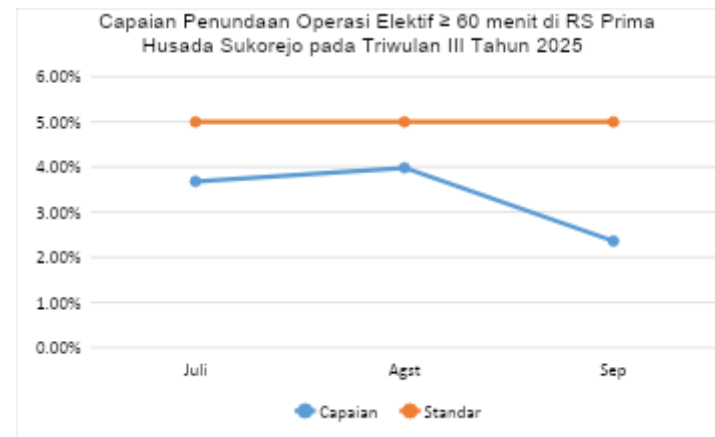
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 67,97% dan belum mencapai target 80%. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan yakni 1 jam 7 menit melebihi standar maksimal 60 menit.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan
Plan	2. Masalah yang ditemukan : Rata-rata waktu tunggu rawat jalan masih tinggi, yakni 1 jam 7 menit, dengan tingkat kepatuhan terhadap standar waktu tunggu $\leq$ 60 menit hanya sebesar 67,97%.

	3. Tujuan : 4. Meningkatkan persentase kepatuhan standar waktu tunggu ≤ 60 menit menjadi minimal 80% pada triwulan berikutnya. 2. Rencana Aksi: 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Memonitor waktu kedatangan dokter dan jumlah pasien menumpuk di awal waktu praktik. 2. Melakukan edukasi kepada seluruh petugas front office dan pendaftaran tentang pentingnya efisiensi waktu tunggu.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan Triwulan III yakni 67,97% belum mencapai $\geq 80\%$. 2. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 7 menit. Ini dikarenakan: - Penumpukan Pasien di Awal Jam Poli - Beberapa dokter spesialis tidak datang tepat waktu sesuai jadwal praktik yang telah ditentukan,
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit yakni 67,97% belum mencapai $\geq 80\%$. Rata-rata keterlambatan terjadi dalam waktu 1 jam 7 menit. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penjadwalan ulang atau pembagian tugas pasien di poli untuk DPJP	Meningkatkan pemerataan pasien per DPJP dan mengurangi waktu tunggu	Pasien rawat jalan di poli spesialis	- Review kuota pasien per DPJP - Penjadwalan slot waktu per dokter	Komite Medik, Koordinator Poli	Satu bulan
2	Monitoring kedatangan dokter dan evaluasi disiplin waktu praktik	Mengurangi waktu tunggu awal poli	Dokter Poli Rawat Jalan	Rapat koordinasi dengan Kabid Pelayanan & Komite Medik	Kabid Pelayanan & Komite Medik	Satu bulan
3	Edukasi pasien untuk datang sesuai jadwal melalui call center/pendaftaran online	Meningkatkan kedisiplinan waktu kedatangan pasien sesuai slot waktu	Pasien rawat jalan	- Petugas call center memberi reminder jam kedatangan saat reservasi - Edukasi saat konfirmasi jadwal online	Pendaftaran & CSO	Satu bulan

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

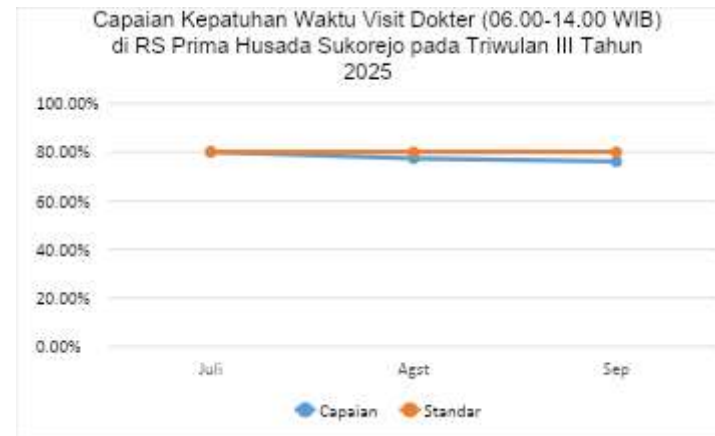


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III tahun 2025 yakni 3,34%. Capaian ini sudah mencapai standar $< 5\%$.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 77,82% belum memenuhi standar minimal $\geq 80\%$. Capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu, sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 77,82% belum mencapai standar 80%
Step	Analisa kepatuhan waktu visite dilakukan setiap bulan melalui monitoring dan rekap data visite dokter dari unit rawat inap, dengan membandingkan waktu kunjungan aktual terhadap waktu yang ditentukan
Plan	3. Identifikasi Masalah : 1. Beberapa dokter spesialis belum melaksanakan visite pasien tepat waktu sesuai jadwal kerja RS. 2. Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. 3. Terdapat dokter yang cuti, tapi digantikan oleh dokter jaga Tujuan : 1. Meningkatkan rata-rata kepatuhan visite minimal 80% Rencana Aksi: 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat).

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

	4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? 1. Pelaksanaan Visit Rutin Sesuai Jam yang Ditentukan (Pagi ≤ 14.00 WIB) 2. Waktu visit dicatat dalam rekam medis dan checklist visit. 3. Dokumentasi kunjungan DPJP melalui tanda tangan/paraf di form visite sebagai bukti telah dilakukan.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 77,82% yang berarti telah memenuhi standar minimal ≥80%. Namun, sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik. Ketidaktepatan waktu ini berisiko menyebabkan keterlambatan dalam: 1. Pengambilan keputusan medis 2. Pelaksanaan terapi 3. Perencanaan pemulangan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak lanjut dan pengawasan rutin untuk meningkatkan mutu pelayanan medik
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 77,82%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai ≥ 80%. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit harian oleh kepala ruangan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang datang ≥ 14.00	Rapat koordinasi dengan komite medik	Kepala Ruang	Satu bulan
2	Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Seluruh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di rumah sakit	Rapat Koordinasi dengan SDM	Komite Medik & SDM	Satu bulan
3	Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat)	Menjamin kontinuitas pelayanan medis melalui penggantian DPJP saat cuti	Dokter Penanggung jawab Pasien	Menetapkan DPJP pengganti resmi saat dokter cuti, dan mendokumentasikannya secara formal.	Kepala Bidang Pelayanan	Satu bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
4	Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritas pasien kritis	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada pasien rawat inap khususnya pasien kritis di ICU melalui sistem koordinasi dan prioritas yang lebih baik.	Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan pasien kritis yang dirawat di ICU	- Menyusun daftar harian pasien kritis yang membutuhkan prioritas visite. - Melaksanakan koordinasi pagi antara perawat ICU dan DPJP sebelum jam visite	Kepala Ruang ICU, DPJP, Komite Medi	Satu bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 60 menit



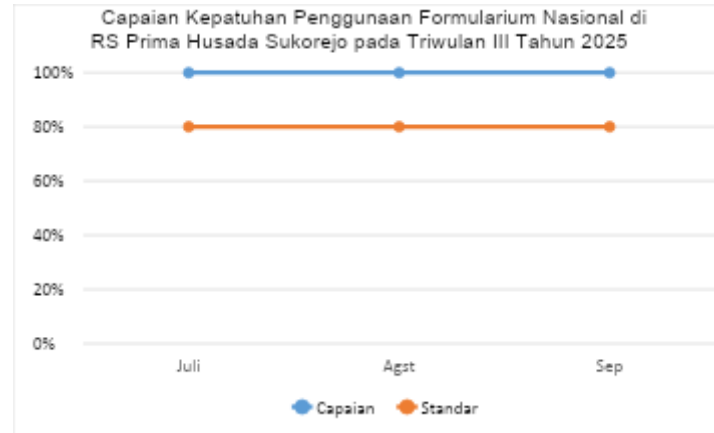
Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Triwulan III Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi, hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

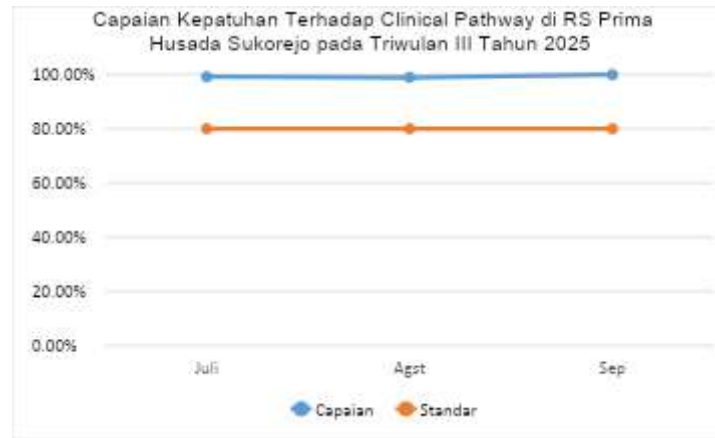


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan persepsan obat hanya dari Formularium Nasional.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)



Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Triwulan III Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 99,39%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Triwulan III didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan III tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% 2. Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni dan Juli 2025, belum seluruh petugas melaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar

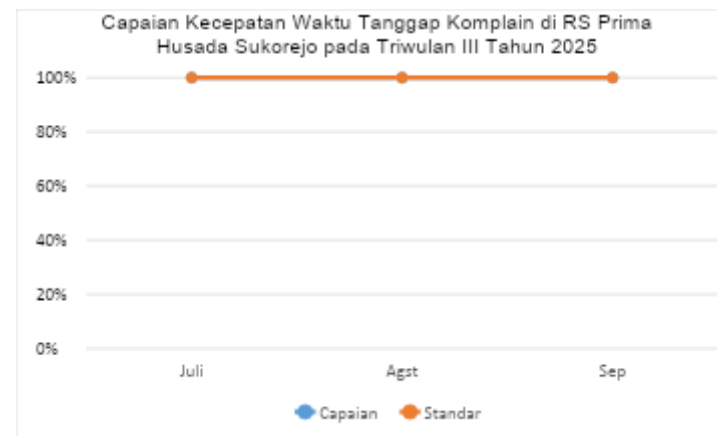
	5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% 2. Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). 3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak terempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,29% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan pasien risiko jatuh	Seluruh petugas di unit pelayanan yang menangani pasien risiko jatuh	Penguatan edukasi melalui briefing harian	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Memastikan hand rail terpasang di tempat tidur pasien risiko jatuh	Menjamin keamanan fisik pasien	Pasien risiko tinggi jatuh	• Ceklist ketersediaan hand rail per shift • Koordinasi dengan bagian pemeliharaan	Ka. Ruangan IPSRS	Satu Bulan
3	Pengadaan dan penggunaan stiker serta penanda visual risiko jatuh	Meningkatkan kesadaran visual terhadap pasien berisiko	Petugas dan keluarga pasien	• Standarisasi label risiko jatuh • Distribusi ulang penanda ke tiap unit	Gudang Tim mutu	Satu Bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
4	Audit rutin kepatuhan tindakan pencegahan risiko jatuh	Monitoring implementasi di lapangan	Setiap unit rawat inap	Observasi lapangan	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan
5	Pemberian umpan balik langsung	Meningkatkan perbaikan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh	- Laporan hasil audit dibagikan tiap unit - Tindak lanjut individu	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

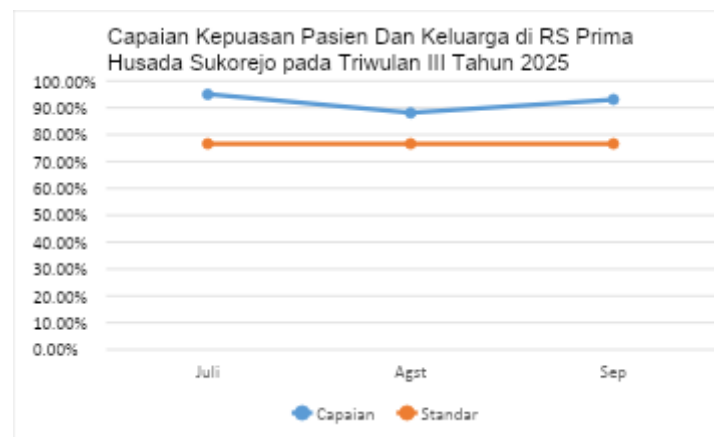


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 92,07%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

Berikut merupakan tabel capaian Indikator Mutu Nasional (IMN) Triwulan IV di RS Prima Husada Sukorejo

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	74,75%	77,24%	78,95%	83,80%	81,66%	88,59%	76,39%	75,98%	74,81%	79,38%	89,47%	89,62%	≥85%	80,89%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	89,64%	89,87%	84,84%	97,92%	98,07%	93,83%	92,01%	83,84%	83,55%	91,48%	97,28%	92,31%	100%	97,66%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	98,30%	99,76%	99,66%	99,65%	99,73%	98,97%	99,80%	99,56%	99,68%	99,70%	99,72%	99,71%	100%	99,52%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	95,45%	92,31%	100%	96,77%	85,71%	100%	100%	97,30%	100%	95,00%	80,95%	82,35%	≥80%	93,82%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	71,25%	68,24%	45,81%	74,78%	70,14%	79,70%	64,29%	77,96%	61,67%	98,48%	85,19%	98,12%	≥80%	75,75%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	0%	3,43%	1,08%	4,52%	1,37%	3,84%	3,68%	3,98%	2,36%	4,05%	3,17%	2,83%	≤5%	2,86%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	71,77%	72,57%	76,56%	71,19%	74,97%	77,96%	80,09%	77,28%	76,10%	71,64%	73,62%	67,75%	≥80%	74,29%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,70%	96,98%	98,70%	98,44%	98,84%	98,75%	99,19%	98,99%	100%	99,02%	100%	100%	≥80%	99,05%	Dipertahankan

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	95,95%	96,65%	96,25%	97,44%	97,99%	98,75%	98,63%	97,68%	98,55%	98,35%	97,84%	97,84%	100%	97,66%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	97,87%	94,12%	96,30%	95,00%	88,10%	93,10%	87,50%	96,23%	90,74%	≥76.61%	93,52%	Dipertahankan

Analisis Hasil Capaian Indikator Mutu Nasional (IMN) Triwulan IV di RS Prima Husada Sukorejo

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Tahun 2025 yakni mencapai 80,89% masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu > 85%. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Bulan Desember Tahun 2025

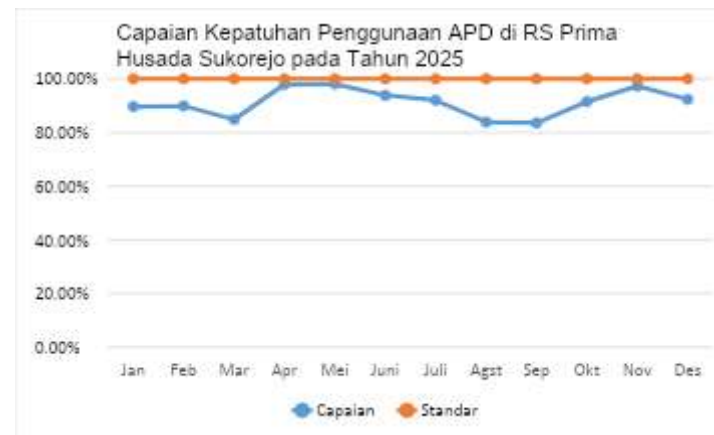
Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Tahun 2025 yakni 80,89% belum mencapai target 85%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Kepatuhan kebersihan tangan pada tahun 2025 yakni 80,09% belum mencapai target 85% - Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. - Pengawasan langsung tidak bisa maksimal dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga - Tujuan: - Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan 85% - Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan - Rencana Aksi: - Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Menambah dan memastikan ketersediaan handrub di seluruh titik pelayanan pasien
Do	- Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dengan pembinaan langsung kepada petugas yang tidak patuh, disertai pencatatan tindak lanjut di buku unit pemantauan - Melibatkan PIC promkes/IPCLN dalam memberikan edukasi singkat tentang “5 Momen & 6 Langkah Kebersihan Tangan” saat briefing mingguan
Study	- Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan pada Tahun 2025 yaitu 80,89% - Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO
Action	- Kepala unit wajib melakukan kebersihan tangan sesuai 5 momen di depan staf sebagai teladan. - Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dengan pembinaan langsung kepada petugas yang tidak patuh, disertai pencatatan tindak lanjut di buku unit pemantauan - Mengintegrasikan hasil audit dan pembinaan ke dalam rapat mutasi bulanan sebagai bagian dari evaluasi program PPI.

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

1	Kepala unit wajib melakukan kebersihan tangan sesuai 5 <i>momen</i> di depan staf sebagai teladan.	Menumbuhkan budaya teladan dan kepemimpinan dalam penerapan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di unit kerja.	<i>Pendekatan role model</i> : kepala unit memperagakan langsung pemenuhan kebersihan tangan di setiap shift	Kepala Unit, Seluruh Staf Unit	Setiap awal shift
2	Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dan melakukan pelatihan langsung kepada petugas yang tidak patuh, serta mencatat tindak lanjut di buku unit pemantauan.	Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan melalui pelatihan langsung dan pemantauan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh terhadap kebersihan tangan.	<i>Pendekatan coaching on the spot</i> berdasarkan hasil audit harian untuk koreksi perilaku secara real time.	Kepala Unit, IPCN/IPCLN	Harian
3	Mengintegrasikan hasil audit dan pembinaan ke dalam rapat mutasi bulanan sebagai bagian dari evaluasi program PPI.	Menjamin keinginan monitoring dan evaluasi pemenuhan kebersihan tangan.	Manajemen RS, Komite PPI, Kepala Unit.	Integrasi hasil audit dan pelatihan dalam agenda rapat mutual sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.	Komite PPI, Manajemen Mutu, Kepala Unit	Bulanan

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Tahun 2025 yakni mencapai 91,22% dan belum mencapai standar 100%.

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2025

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 91,22%.
Step	Melakukan penguatan edukasi berkelanjutan dan monitoring langsung kepada seluruh staf, khususnya kepada kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 91,22%. - Setelah dua kali pelatihan (umum dan khusus), masih ditemukan staf yang belum konsisten dalam penggunaan APD sesuai prosedur. - Tujuan: - Meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD hingga mencapai 100%, khususnya pada unit yang telah mendapatkan pelatihan. - Rencana Aksi: - Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD hingga $\geq 95\%$ dalam 1–2 bulan berikutnya - Fokus pada unit dan pergeseran dengan kepatuhan $< 90\%$.
Do	- Memberikan feedback dan pembinaan langsung kepada staf yang ditemukan tidak sesuai prosedur. - Pelaporan hasil audit secara rutin di grup PPI untuk transparansi dan pembelajaran antarunit.
Study	- Capaian pada tahun 2025 yakni 91,22% - Pelaporan di grup PPI meningkatkan kesadaran, namun belum sepenuhnya konsisten untuk semua unit.
Action	- Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. - Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian. - Menyertakan pencapaian APD dalam rapat umum bulanan sebagai indikator evaluasi kinerja unit.

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN	Mendeteksi dini ketidakpatuhan dan memberikan pembinaan langsung	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	- Observasi langsung - Pembinaan di tempat (real-time coaching) - Dokumentasi dan tindak lanjut langsung	IPCN, IPCLN	1 Bulan
2	Penyusunan dan distribusi SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan Non-Medis	Menyediakan panduan praktis dan mudah dipahami di area kerja	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	SPO 1 lembar disesuaikan dengan risiko kerja	Tim IPC, Tim PMKP, Kepala Unit	1 Bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
				- Poster visual dipasang di area kerja - Sosialisasi singkat per shift		
3	Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk mengoordinasikan dan melaporkan ketidaksesuaian harian	Pengawasan berkelanjutan dan penegakan disiplin penggunaan APD	Kepala ruangan (Karu)	- Pemantauan harian - Pencatatan ketidaksesuaian - Pelaporan ke kepala unit atau grup PPI.	Kepala Ruang, IPCN, IPCLN	Harian
4	Menyertakan pencapaian APD dalam rapat umum bulanan sebagai indikator evaluasi kinerja unit	Terwujudnya APD sebagai indikator saling menguntungkan dan keselamatan pasien, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan	Manajemen RS, Komite PPI, Kepala Unit, seluruh staf	Presentasi pencapaian bulanan dan analisis tren kepatuhan, diikuti rekomendasi perbaikan.	Kepala Ruang	1 Bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 mencapai 99,52%. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,52%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 4 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, dan Maternitas. Akar Masalah yang teridentifikasi: 1. Beberapa tindakan pasien tidak melakukan pengecekan gelang identitas (TL / Tidak Cek Gelang) 2. Meskipun rata-rata terpenuhinya keseluruhan 99,72%, ada unit tertentu (misal Maternitas, IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A) yang masih muncul kasus ketidakpatuhan. 3. Risiko kesalahan identitas pasien tetap ada meskipun jumlah kasus kecil. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : 1. Menjaga kepatuhan $\geq 99\%$ di semua unit. 2. Fokus perbaikan pada kasus TL atau tidak cek gelang.
Do	1. Pengumpulan data yang menyertakan pasien dari SIMRS dan manual audit. 2. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 3. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 4 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A dan Maternitas. 2. Indikator menunjukkan tren stabil dan sangat baik, namun ada peluang perbaikan kecil pada prosedur pengecekan gelang.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Bulan Desember tahun 2025 mencapai 99,52%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Menetapkan <i>bedside coaching</i> bagi petugas di unit dengan kasus TL atau tidak cek gelang. 2. Memberikan apresiasi kepada unit/staf yang 100% patuh. 3. Supervisi langsung harian

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menetapkan <i>Bedside Coaching</i> bagi petugas di unit dengan kasus TL atau tidak cek gelang	Meningkatkan kompetensi dan kepatuhan petugas secara langsung di area kerja.	Petugas di unit dengan insiden ketidakpatuhan (kasus TL / tidak cek gelang).	Pelatihan personal (satu-satu) dan praktik langsung di samping pasien untuk koreksi teknik yang tepat.	Kepala Unit & Tim Mutu	Satu bulan.
2	Memberikan apresiasi kepada unit/staf yang 100% patuh	Mendorong dan mempertahankan budaya kepatuhan serta memberikan motivasi positif.	Unit dan staf yang mencapai tingkat kepatuhan 100% terhadap Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) tertentu.	Pengakuan publik (misalnya, <i>Reward of the Month</i>)	Staf SDM.	Triwulanan
3	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit



Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 93,82%. Dari pasien yang diobservasi, pasien telah mendapatkan pelayanan tanggap SC Emergency lebih dari 60 menit. Secara keseluruhan Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 mencapai 75,75% dan belum mencapai standar 80%. Tetapi pada Bulan Oktober sampai Desember 2025 telah melampaui standar minimum yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Kesehatan, yaitu $\geq 80\%$. Data ini diambil dalam fitur Antrian *Online* dari Mobile JKN.

Capaian selama Bulan Oktober sampai Desember Tahun 2025 mengartikan rumah sakit memanfaatkan fitur Antrian *Online* dari Mobile JKN secara maksimal, sehingga pasien datang sudah terdaftar dan siap dilayani (mengurangi *waiting time* di loket). Dan juga data yang diambil langsung dari *database* BPJS lebih akurat, mengurangi waktu yang terbuang untuk koreksi data administrasi.

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit



Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif $\geq$ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada tahun 2025 yakni 2,86%. Capaian ini sudah mencapai standar $< 5\%$.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB)
di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 74,29% belum memenuhi standar minimal $\geq 80\%$. Capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu, sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Tahun 2025

Problem	Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 74,29% belum mencapai standar 80%
Step	Analisa kepatuhan waktu visite dilakukan setiap bulan melalui monitoring dan rekap data visite dokter dari unit rawat inap, dengan membandingkan waktu kunjungan aktual terhadap waktu yang ditentukan
Plan	2. Identifikasi Masalah : - Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. Tidak sesuai dengan ketentuan waktu kunjungan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan (<14.00). - Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya jumlah dokter home base, serta adanya jadwal praktik lintas rumah sakit yang menyebabkan dokter tidak selalu dapat melakukan kunjungan pada jam kerja RS. - Selain itu, masih terdapat dokter spesialis yang belum melaksanakan kunjungan secara tepat waktu dan teratur, sesuai standar pelayanan medik dan kebijakan rumah sakit. Tujuan :

	1. Meningkatkan Capaian <i>Visit</i> Dokter 06.00-14.00 WIB dengan target 80%
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? 1. Pendelegasian ICU: Meminta DPJP yang sibuk untuk mengonsultasikan/menitipkan instruksi pasien ICU kepada Dokter Jaga secara terstruktur sebelum pukul 14.00 WIB. 2. <i>Tele-Consult</i> : Mendorong penggunaan komunikasi jarak jauh (telepon/aplikasi terintegrasi) untuk <i>visit</i> awal (sebelum dokter tiba) jika memungkinkan
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Tahun 2025 yakni 74,29% belum mencapai standar. Namun, sebagian dokter spesialis belum melaksanakan <i>visite</i> secara tepat waktu sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik. Ketidaktepatan waktu ini berisiko menyebabkan keterlambatan dalam: 1. Pengambilan keputusan medis 2. Pelaksanaan terapi 3. Perencanaan pemulangan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak lanjut dan pengawasan rutin untuk meningkatkan mutu pelayanan medik
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Tahun 2025 yakni 74,29%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu <i>visite</i> dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Buat Formulir <i>Handover</i>/Pendelegasian Terstruktur untuk instruksi pasien yang dititipkan ke Dokter Jaga, lengkap dengan tanda tangan DPJP dan Dokter Jaga sebagai bukti tanggung jawab bersama . 2. Khusus untuk pasien ICU yang membutuhkan <i>visit</i> harian, Manajemen (Komite Medis) perlu bernegosiasi dengan DPJP untuk menetapkan waktu on-call standby minimal pada jam tertentu (12.00-14.00) untuk kasus ICU.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penyusunan dan Implementasi Formulir <i>Handover</i> /Pendelegasian Terstruktur	Menjamin keselamatan pasien dan akuntabilitas instruksi medis pada kasus yang dititipkan (didelegasikan) ke Dokter Jaga.	Menghilangkan risiko kesalahan komunikasi (<i>missed instructions</i>) dan memastikan <i>visit</i> 06.00-14.00 terdokumentasi, meskipun DPJP tidak hadir secara fisik	1. Tim Mutu/Komite Medis merancang formulir yang mencakup: Identitas Pasien, Alasan Pendelegasian, Instruksi Baru, Instruksi Lama, dan Kolom Tanda Tangan DPJP dan Dokter Jaga. 2. Sosialisasi intensif kepada DPJP dan Dokter Jaga.	Komite Medis, Komite Keperawatan, Manajer Pelayanan, Tim Mutu	1-2 Minggu (Penyusunan dan Sosialisasi).
2	Negosiasi Penetapan Waktu <i>On-Call Standby</i> Minimal DPJP ICU (Jam 12.00-14.00 WIB)	Memastikan ketersediaan DPJP minimal pada jam kritis untuk pasien ICU	Meningkatkan kualitas <i>visit</i> harian ICU dan mengurangi risiko keterlambatan	Ketua Komite Medis/Direktur Pelayanan bernegosiasi langsung dengan DPJP ICU untuk alokasi	Komite Medis, Kepala Unit ICU.	1 bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
		yang memerlukan <i>assessment</i> langsung atau keputusan cepat.	penanganan kasus kritis yang tidak bisa didelegasikan.	waktu <i>standby</i> harian pada jam 12.00-14.00 WIB (minimal <i>standby</i> untuk dihubungi/datang jika mendesak).		

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 60 menit

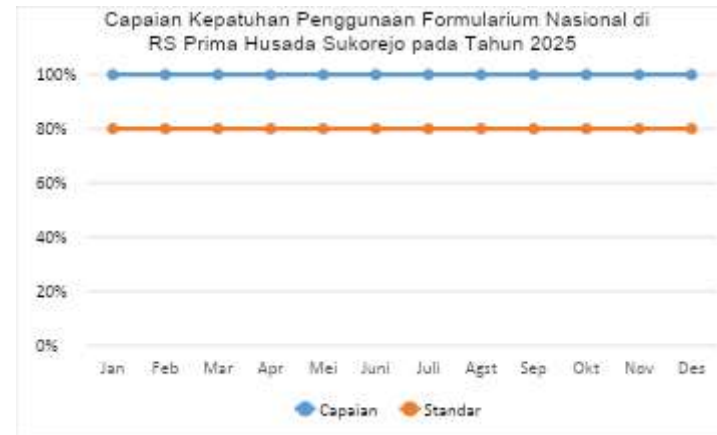


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi, hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

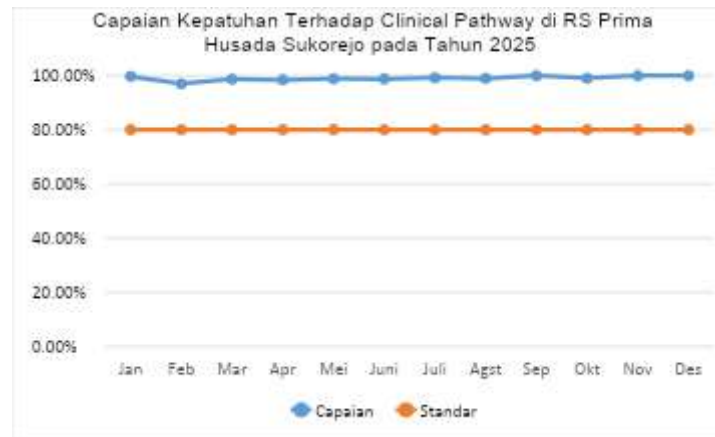


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan persepan obat hanya dari Formularium Nasional.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)



Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 99,05%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan Desember didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada tahun 2025 adalah 97,66%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025 adalah 97,66%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 97,66% 2. Ini dikarenakan handrail tidak terpasang atau terkunci dengan baik dan tidak terpasang stiker resiko jatuh Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 97,66% 2. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 3. kasus Stiker Tidak Terpasang terjadi pada pasien baru yang <i>assessment</i>-nya selesai di luar jam sibuk dan penundaan pemasangan stiker.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 97,66% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten

4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar
5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan pasien risiko jatuh	Seluruh petugas di unit pelayanan yang menangani pasien risiko jatuh	Penguatan edukasi melalui briefing harian	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Memastikan hand rail terpasang di tempat tidur pasien risiko jatuh	Menjamin keamanan fisik pasien	Pasien risiko tinggi jatuh	- Ceklist ketersediaan hand rail per shift - Koordinasi dengan bagian pemeliharaan	Ka. Ruangan IPSRS	Satu Bulan
3	Pengadaan dan penggunaan stiker serta penanda visual risiko jatuh	Meningkatkan kesadaran visual terhadap pasien berisiko	Petugas dan keluarga pasien	- Standarisasi label risiko jatuh - Distribusi ulang penanda ke tiap unit	Gudang Tim mutu	Satu Bulan
4	Audit rutin kepatuhan tindakan pencegahan risiko jatuh	Monitoring implementasi di lapangan	Setiap unit rawat inap	Observasi lapangan	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan
5	Pemberian umpan balik langsung	Meningkatkan perbaikan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh	- Laporan hasil audit dibagikan tiap unit - Tindak lanjut individu	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain



Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 93,52%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

Data Surveilans HAI's di RS Prima Husada Sukorejo

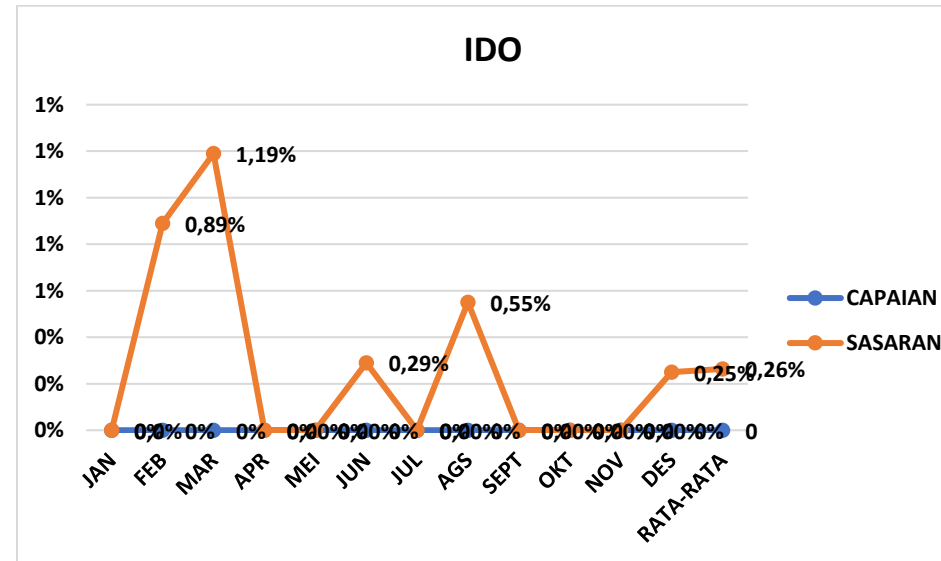
NAMA INDIKATOR	STANDART	BULAN KE-												RATA-RATA DALAM 1 TAHUN	RATA2 SM 1	RATA2 SM 2
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
IDO	<2 %	0,00%	0,59%	1,19%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,21%	0,34%	0,09%
IADP	<3,5 PER MIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP	<5,8 PER MIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISK	<4,7 PER MIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLEBITIS	<5 %	1,39%	1,14%	2,41%	2,08%	3,49%	3,46%	2,27%	2,88%	3,41%	3,73%	2,55%	2,68%	2,62%	2,33%	2,92%
DEKUBITUS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0833333333	0	0,17

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

1. IDO



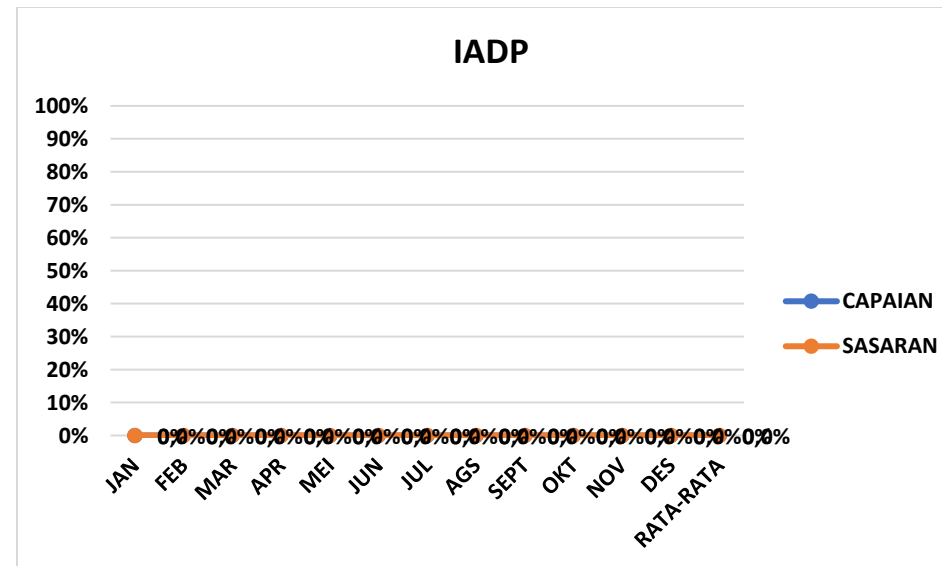
Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.2 diketahui bahwa rerata kejadian IDO belum mencapai standart 0% pada tahun 2025.

Tabel 4.1.2.3 PDSA Bundle IDO

PROBLEM	Persentase kejadian IDO pada tahun 2025 rerata sebesar 0,26% dan belum mencapai standar 0%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IRJA, IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian IDO untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
PLAN	- Rencana: Menurunkan angka kejadian IDO menjadi <0,2% dalam 3 bulan kedepan. - Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian IDO dan dapat menurunkan kejadian IDO di masing-masing unit.

	3. Akar masalah yang diidentifikasi; a. Kepatuhan aseptis saat operasi belum maksimal b. Sterilisasi alat belum diaudit secara menyeluruh c. Monitoring luka pascaoperasi belum optimal d. Monitoring pasien pasca operasi di rumah belum bisa berjalan dengan baik terutama terkait asupan gizi dan mobilisasi pasien 4. Tindakan a. Penegakkan protokol aseptis secara ketat (5 momen kebersihan tangan, sterilisasi alat, dan penggunaan APD yang sesuai) b. Pemberian antibiotik profilaksis 30-60 menit sebelum insisi c. Audit sterilisasi alat operasi d. Monitoring luka operasi dan edukasi pasien post-op
DO	Angka kejadian IDO dapat mencapai 0% dengan menerapkan, 1. Terapkan sistem checklist pre-op untuk memastikan pemberian antibiotik 2. Audit harian pada ruang operasi dan rawat inap pasca-operasi 3. Edukasi psien dan keluarga tentang perawatan luka di rumah
STUDY	1. Data kejadian IDO pada bulan Desember sebesar 1 kejadian dengan rerata kejadian 0,25% dan belum mencapai target 0% 2. Tinjau tren angka IDO setiap minggu 3. Lakukan evaluasi melalui audit kepatuhan prosedur dan insiden harian 4. Identifikasi apakah terjadi penurunan kejadian dan kepatuhan meningkat
ACTION	1. Jika angka IDO menurun : terapkan prosedur sebagai standar dan teruskan monitoring 2. Jika belum berhasil maka, a. Perbaiki SOP sesuai temuan lapangan b. Tambah frekuensi supervise dan audit c. Evaluasi kinerja individu yang tidak patuh dan lakukan pembinaan

2. IADP



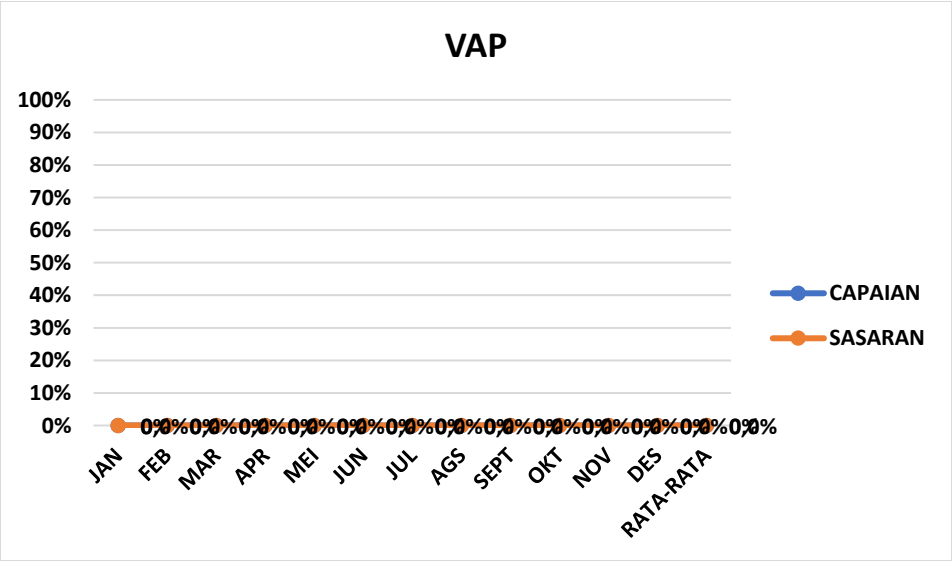
Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.5 diketahui bahwa rerata kejadian IADP pada Tahun 2025 sebesar 0 kejadian

Tabel 4.1.2.5 PDSA IADP

PROBLEM	Angka Sasaran IADP saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle IADP) perlu diverifikasi dan distandardisasi untuk mencegah lonjakan insiden di masa mendatang.
STEP	Audit Kepatuhan pada Perawatan dan Pemeliharaan <i>Central Line</i> : Memfokuskan audit pada Perawatan Balutan (<i>Dressing</i>) dan Penggunaan <i>Checklist</i> Harian Pelepasan Kateter sentral.
PLAN	1. Tujuan (Goal): Mempertahankan angka insiden IADP 0% sambil mencapai 95% kepatuhan terhadap Bundel Perawatan

	Kateter Sentral. 2. Tindakan (Implementasi): - Sosialisasi ulang prosedur dan teknik steril penggantian balutan kateter sentral. - Menerapkan <i>checklist</i> evaluasi harian untuk menilai perlunya pelepasan kateter sentral (<i>daily necessity review</i>). - Perawat ruang rawat intensif (ICU) diwajibkan melakukan <i>time-out</i> singkat sebelum penggantian balutan. 3. Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kepatuhan penggantian balutan sesuai jadwal dan teknik. - Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>checklist</i> harian evaluasi pelepasan kateter. - Indikator Hasil: Angka Sasaran IADP bulanan (Target: 0%).
DO	- Melakukan pelatihan kepada perawat unit terkait (ICU/NICU/unit berisiko tinggi). - Menerapkan <i>checklist</i> harian evaluasi pelepasan kateter pada semua pasien yang terpasang <i>central line</i>. - Tim PPI/Pengawas melakukan audit observasi langsung (minimal 5 kali per minggu) terhadap kepatuhan penggantian balutan.
STUDY	- Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: - Penggantian balutan steril dan tepat waktu. - Pengisian <i>checklist</i> pelepasan harian. - Analisis Hasil: Memastikan Angka Sasaran IADP tetap 0% selama periode uji coba. * Pertanyaan: Jika insiden 0%, apakah kepatuhan terhadap proses (audit) juga sudah tinggi (>95%)? - Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah (meskipun insiden 0%): - Apakah beban kerja perawat terlalu tinggi? - Apakah pasokan <i>dressing kit</i> steril tidak tersedia dengan baik?
ACTION	- Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan proses mencapai >95% dan insiden tetap 0%, standardisasikan <i>checklist</i> pelepasan harian dan <i>time-out</i> balutan ke seluruh unit dan masukkan ke dalam sistem manajemen mutu. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif dan <i>reward</i> kepada unit untuk mempertahankan kinerja 0% IADP - Siklus Baru (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan sistem pendukung (misalnya, membuat sistem pengadaan <i>dressing kit</i> menjadi lebih efisien) atau pada elemen bundel CLABSI lain (misalnya, kepatuhan <i>hand hygiene</i> sebelum manipulasi <i>line</i>).

3. VAP



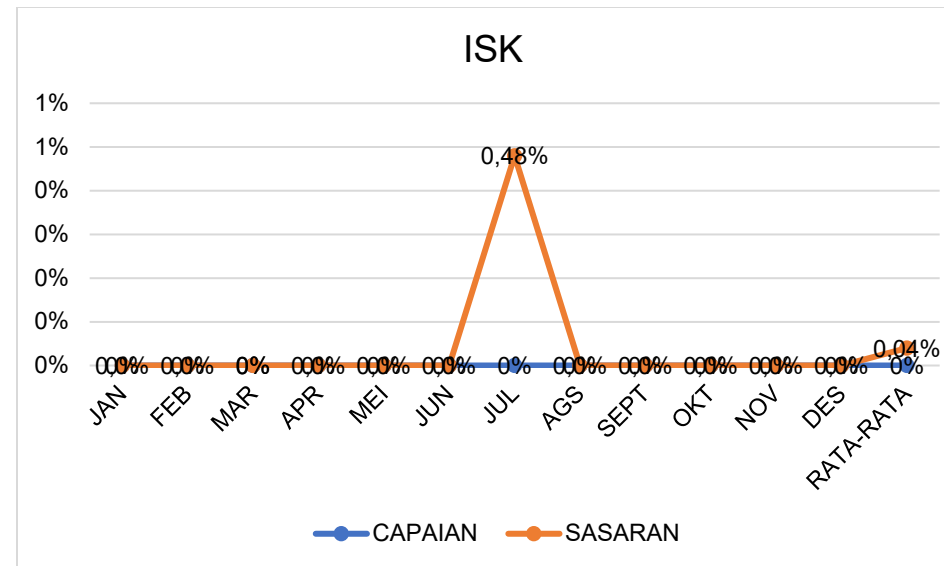
Interpretasi : Pada gambar diketahui bahwa rerata kejadian VAP di Tahun 2025 sebesar 0 kejadian

Tabel 4.1.2.5 PDSA VAP

PROBLEM	Angka Sasaran VAP saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle VAP) perlu diverifikasi dan ditingkatkan untuk menjamin hasil yang berkelanjutan dan mencegah <i>zero-report</i> yang palsu
STEP	Audit Kepatuhan pada 2 Elemen Inti Bundle VAP: Memfokuskan audit pada 1) Elevasi Kepala Tempat Tidur (30° hingga 45°) dan 2) Penghentian Sedasi Harian (<i>Daily Sedation Interruption</i>).
PLAN	1. Tujuan (Goal): Mempertahankan angka insiden VAP 0% sambil mencapai 95% kepatuhan terhadap Elemen Kunci Bundel VAP. 2. Tindakan (Implementasi): a. Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai pentingnya elevasi kepala 30° hingga 45° untuk semua pasien yang terintubasi. b. Menerapkan stiker atau <i>reminder</i> visual di samping tempat tidur pasien untuk mencatat waktu penghentian sedasi harian (<i>sedation vacation</i>). c. Dokter dan Perawat ICU diwajibkan mencatat <i>reason (alasan)</i> jika elevasi kepala kurang dari 30° hingga 45° atau jika <i>sedation</i>

	<i>vacation</i> tidak dilakukan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan elevasi kepala 30° hingga 45°. b. Indikator Proses: Persentase <i>Daily Sedation Interruption</i> yang berhasil dilakukan. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran VAP bulanan (Target: 0%).
DO	1. Menerapkan <i>reminder</i> visual dan pencatatan alasan pengecualian di setiap <i>bedside</i>. 2. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi mendadak (minimal 2 kali per minggu) untuk mengecek posisi kepala tempat tidur dan pencatatan <i>sedation vacation</i>.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Elevasi kepala 30° hingga 45° b. Pelaksanaan <i>Daily Sedation Interruption</i>. 2. Analisis Hasil: Memastikan Angka Sasaran VAP tetap 0% selama periode uji coba. Pertanyaan: Jika insiden 0%, apakah kepatuhan terhadap proses (audit) juga sudah tinggi (>95%)? 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah (meskipun insiden 0%): a. Apakah ranjang tidak berfungsi dengan baik (<i>technical issue</i>) sehingga sulit mencapai 30° hingga 45° b. Apakah dokter atau perawat khawatir akan efek samping <i>sedation vacation</i> (misalnya, ekstubasi diri)?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan proses mencapai >95% dan insiden tetap 0%, standardisasikan penggunaan <i>reminder</i> visual dan wajibkan pencatatan alasan pengecualian dalam rekam medis. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif dan penghargaan kepada unit ICU untuk mempertahankan kinerja 0% VAP. 3. Siklus Baru (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan peralatan (jika ranjang rusak) atau pada elemen bundel VAP lain (misalnya, perawatan kebersihan mulut <i>oral hygiene</i>) jika audit proses menunjukkan ini sebagai area terlemah.

4. ISK



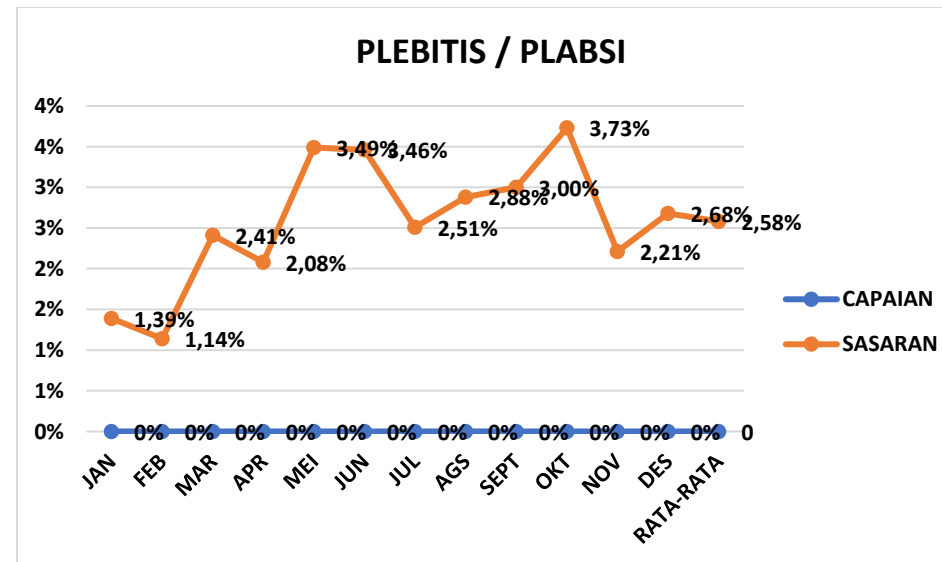
Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.4 diketahui bahwa rerata kejadian ISK di Tahun 2025 sebesar 0 kejadian

Tabel 4.1.2.4 PDSA CAUTI

PROBLEM	Terjadi lonjakan Angka Sasaran ISK hingga 0,48% pada bulan Juli, menunjukkan ketidakpatuhan atau kegagalan sistem dalam penerapan Bundle ISK. Target ideal (0%) belum tercapai.
STEP	Menerapkan audit kepatuhan harian yang ketat pada: 1. Ketepatan Indikasi Pemasangan Kateter dan 2. Kebersihan Tangan (<i>Hand Hygiene</i>) saat perawatan kateter.
PLAN	1. Tujuan (Goal): Menurunkan Angka Sasaran ISK menjadi 0% dalam periode uji coba 1 bulan. 2. Tindakan (Implementasi): a. Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai 5 indikasi yang diperbolehkan untuk pemasangan kateter urin. b. Menerapkan "Stiker/Label Harian" pada tas urin pasien yang mencantumkan tanggal pemasangan dan indikasi. c. Tim pengawas/PPI melakukan observasi mendadak (<i>spot check</i>) terhadap kepatuhan kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan kateter urin. 3. Pengukuran:

	a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap indikasi pemasangan kateter. b. Indikator Proses: Persentase kepatuhan kebersihan tangan perawat sebelum/sesudah perawatan. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran ISK bulanan (diukur dalam 1 bulan berikutnya).
DO	1. Melakukan pelatihan kepada perawat dan dokter. 2. Menerapkan Stiker/Label Harian pada semua pasien yang terpasang kateter di unit uji coba. 3. Memulai audit harian kepatuhan kebersihan tangan dan audit kebutuhan pelepasan kateter (penilaian setiap hari apakah kateter masih diperlukan). 4. Tim PPI/Pengawas mengumpulkan data kepatuhan proses setiap akhir minggu.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: d. Ketepatan Indikasi Pemasangan dan Pelepasan Harian Kateter. e. Kepatuhan Kebersihan Tangan saat perawatan. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran ISK pada periode uji coba dengan data lonjakan (Desember 0% dengan rerata 0,04%). * Pertanyaan: Apakah kepatuhan yang meningkat berhasil menurunkan ISK menjadi 0%? 3. Identifikasi Akar Masalah: Jika ISK tetap terjadi atau kepatuhan rendah: * Apakah masalahnya adalah lamanya hari pemasangan (indikasi tidak dievaluasi harian)? * Apakah masalahnya adalah teknik pemasangan yang kurang steril? (Jika elemen kebersihan tangan sudah baik).
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika ISK turun menjadi 0% dan kepatuhan tinggi, standarkan <i>checklist</i> pelepasan harian kateter dan masuk ke dalam SPO. 2. Perluas penerapan Stiker/Label Harian ke seluruh rumah sakit. 3. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil mencapai 0 insiden. 4. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika insiden tetap terjadi, gunakan data dari tahap <i>Study</i> untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya. Fokuskan pada elemen bundel yang belum optimal (misalnya, teknik pemasangan kateter yang steril, atau perawatan meatus urinarius).

5. PHLEBITIS

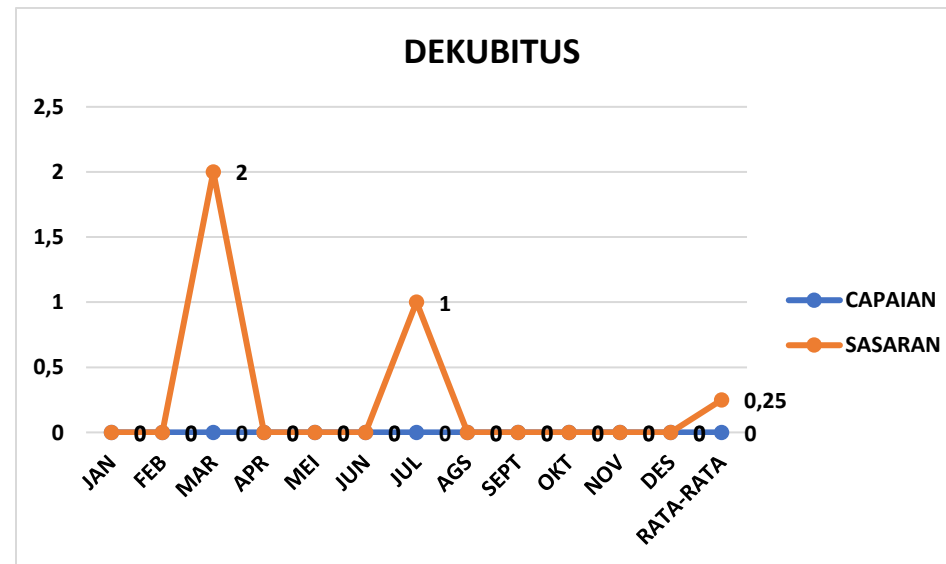


Tabel 4.1.2.2 PDSA Phlebitis

PROBLEM	Persentase kejadian plebitis belum mencapai standart 0%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian plebitis untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
PLAN	- Rencana: Menurunkan angka kejadian phlebitis menjadi $\leq 1\%$ dalam 3 bulan. - Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian plebitis dan dapat menurunkan kejadian plebitis di masing-masing unit. - Akar masalah yang diidentifikasi; - Ketidaksesuaian prosedur pemasangan infus - Lama pemasangan infus >72 jam - Kurangnya pencatatan dan monitoring harian - Minimnya pelatihan atau refreshment untuk tenaga medis - Banyak data phlebitis yang tidak dilaporkan dari unit - Tindakan

	a. Sosialisasi SOP pemasangan dan perawatan infus b. Audit harian terhadap pemasangan dan perawatan infus c. Pembatasan lama pemasangan infus maksimal 72 jam d. Pelatihan ulang tenaga medis tentang pencegahan phlebitis e. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0%.
STUDY	1. Data kejadian phlebitis pada bulan Desember sebesar 2,68% dengan rerata 2,58% dan belum mencapai target 0% 2. Evaluasi angka kejadian phlebitis setiap minggu 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Audit kepatuhan pelaporan bundle plebitis 5. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
ACTION	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika angka tetap tinggi; b. Evaluasi Kembali penyebab utama c. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan d. Pertimbangkan revisi SOP bila tidak sesuai praktik lapangan

6. DEKUBITUS



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.3 diketahui bahwa rerata kejadian Dekubitus pada tahun 2025 dengan rata- rata sebesar 0 kejadian

Tabel 4.1.2.4 PDSA Bundle Dekubitus

PROBLEM	Kejadian dekubitus pada Tahun 2025 sebanyak 0 kejadian
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit rawat inap dan unit khusus (ICU) mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus untuk mengurangi resiko decubitus pada pada pasien tirah baring lama melalui peningkatan kepatuhan terhadap pencegahan luka tekan sesuai dengan standart PPI
PLAN	- Rencana: Menurunkan angka kejadian dekubitus menjadi 0 kejadian dalam 3 bulan . - Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian dekubitus dan dapat menurunkan kejadian dekubitus di masing-masing unit.

	3. Akar masalah yang diidentifikasi; a. Ketidakpatuhan staff dalam melakukan tindakan keperawatan mika-miki pada pasien tirah baring b. Ketidakpatuhan staff melakukan edukasi terkait penggunaan kasur dekubitus 4. Tindakan a. Melakukan skrining risiko dekubitus menggunakan skala Braden pada saat pasien masuk b. Memberikan pelatihan kepada perawat tentang pencegahan luka tekan c. Menyediakan alat bantu seperti Kasur decubitus dan posisi miring berkala (2 jam) d. Edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi dini dan perawatan kulit
DO	Angka kejadian dekubitus dapat mencapai 0 kejadian.
STUDY	1. Data kejadian dekubitus pada bulan Desember sebesar 0 kejadian dengan rerata 0,25 kejadian dan belum mencapai target 0 kejadian 2. Peningkatan kepatuhan dokumentasi perubahan posisi pasien dari 40% menjadi 85% 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Audit kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus di ruangan 5. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
ACTION	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika masih ditemukan kejadian decubitus maka, b. Evaluasi Kembali penyebab utama c. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan d. Melakukan audit bulanan kepatuhan dokumentasi posisi dan perawatan kulit e. Memberikan pelatihan rutin PPI dengan focus pencegahan infeksi dari luka tekan